



CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE **C.I.P.R.E.S**

BAREME DE REFERENCE D'INDEMNISATION DES SEQUELLES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES HARMONISE DES ETATS MEMBRES DE LA ZONE CIPRES



CONTRÔLE - ASSISTANCE - FORMATION - HARMONISATION

Bien gérer pour mieux assurer

**barème de référence d'indemnisation des
séquelles des accidents du travail et des
maladies professionnelles harmonisé
des États membres de la zone CIPRES**

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières	4-6
Figures	7
Glossaire	8
Préambule	10-11
Introduction	13
I. PRINCIPES GENERAUX	14
II. METHODE DU CALCUL DU TAUX D'INCAPACITE	15
II.1. Séquelles résultant de lésions isolées	15
II.2. Infirmités multiples résultant d'un même accident	15
II.3. Infirmités antérieures	15
III. REVISIONS	16
BAREME DE REFERENCE HARMONISE	
I. MEMBRE SUPERIEUR	18-32
I.1. Membre supérieur à l'exclusion de la main	18
I.1.1. Amputations	18
I.1.2. Fractures et luxations	19
I.1.3. Atteinte des fonctions articulaires	21
I.1.4. Pseudarthroses et déformations	24
I.1.5. Séquelles musculaires et tendineuses	25
I.2. La main	26
I.2.1. Amputations	26
I.2.2. Fractures et luxations	29
I.2.3. Atteinte des fonctions articulaires	29
I.2.4. Pseudarthroses et déformations	32
I.3. Ostéite et ostéomyélite	32
II. MEMBRE INFERIEUR	33-42
II.1. Amputations	33
II.2. Fractures et luxations	35
II.3. Atteintes des fonctions articulaires	37
II.4. Pseudarthroses, déformation et raccourcissements	41
II.5. Séquelles Musculaires et Tendineuses	41
II.6. Ostéites et ostéomyélites	42
III. RACHIS	43-44
III.1. Rachis Cervical	43
III.2. Rachis Dorsolombaire	44
III.3. Sacrum et Coccyx	44
IV. CRANE ET SYSTEME NERVEUX	45-54
IV.1. Séquelles osseuses	45
IV.2. Séquelles portant sur le névraxe	45
IV.2.1. Séquelles propres au crâne et à l'encéphale	46
IV.2.2. Séquelles provenant de l'atteinte diffuse des hémisphères ou du tronc cérébral	50
IV.2.3. Séquelles propres à l'atteinte médullaire	50
IV.2.4. Séquelles provenant indifféremment d'atteinte cérébrale ou médullaire	51
IV.2.5. Séquelles portant sur le système nerveux périphérique	52
IV.2.6. Syndrome algodystrophique	54
V. OTO- RHINO-LARYNGOLOGIE	55-58
V.1. Nez	55
V.1.1. Fractures	55
V.1.2. Sténose nasale	55
V.1.3. Perforation de la cloison nasale	55
V.1.4. Rhinites crouteuses (après perte de substance endo-nasale étendue)	55
V.1.5. Troubles olfactifs	55

V.2. Sinus	55
V.2.1. Sinusite maxillaire chronique	55
V.2.2. Sinusites fronto-ethmoïdales ou Sphénoïdales	56
V.2.3. Cranio-Hydrorrhée	56
V.3. Pharynx	56
V.4. Larynx	56
V.4.1. Troubles vocaux	56
V.4.2. Troubles respiratoires	56
V.5. Oreilles	56
V.5.1. Mutilations et cicatrisations vicieuses de l'oreille externe	56
V.5.2. Vertiges et troubles d'équilibre	57
V.5.3. Surdit��	57
V.5.4. Acouph��nes	58
V.5.5. Oreille moyenne	58
V.5.6. Oreille Externe	58
VI. OPHTALMOLOGIE	59-62
VI.1. Alt��ration de la fonction visuelle	59
VI.1.1. C��cit��	59
VI.1.2. Scotome central bilat��ral	59
VI.1.3. Perte compl��te de la vision d'un o��il (l'autre ��tant normal)	59
VI.1.4. Scotome central unilat��ral	59
VI.1.5. Diminution de la vision des deux yeux	59
VI.1.6. Vision p��riph��rique du champ visuel	59
VI.1.7. Vision binoculaire	60
VI.1.8. Troubles du sens chromatique et du sens lumineux	60
VI.1.9. Cas particuliers	60
VI.1.10. Cataractes : traumatiques ou professionnelles	61
VI.1.11. Cas divers	61
VI.2. Annexes de l'��il	61
VI.2.1. Orbit��	61
VI.2.2. Paupi��res	62
VI.2.3. Squelette orbitaire	62
VII. STOMATOLOGIE	63-65
VII.1. Face	63
VII.2. Maxillaire (maxillaire sup��rieur)	63
VII.3. Mandibule (maxillaire inf��rieur)	64
VII.4. Articulation temporo-mandibulaire	64
VII.4.1. Constriction des m��choires	64
VII.4.2. Luxation temporo-maxillaire	64
VII.5. Langue	65
VII.6. N��vralgies	65
VII.7. Dents	65
VII.8. Pharynx	65
VII.9. Cicatrices du visage, des l��vres et de la muqueuse buccale	65
VIII. APPAREIL DIGESTIF	66-69
VIII.1. Bouche et pharynx	66
VIII.2. OEsophage	66
VIII.3. Estomac-duod��num	66
VIII.4. Intestin gr��le (j��junum, il��on)	66
VIII.5. Colon	67
VIII.6. Rectum et anus	67
VIII.7. Paroi abdominale	67
VIII.8. Hernies	68
VIII.9. Fonction h��patobiliaire	68
VIII.10. Fonction pancr��atique exocrine	68
VIII.11. Rate	69

IX. APPAREIL RESPIRATOIRE	70-71
IX.1. Paroi thoracique	70
IX.2. Atteinte de la fonction respiratoire	70
IX.3. Cas particuliers	71
X. APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE	72-74
X.1. Coeur	72
X.1.1. Insuffisance cardiaque	72
X.1.2. Péricarde	72
X.1.3. Myocarde	72
X.1.4. Endocarde	72
X.2. Atteintes vasculaires	73
X.2.1. Aorte	73
X.2.2. Autres artères	73
X.2.3. Veines et lymphatiques	73
X.3. Hypertension artérielle	74
XI. APPAREIL URINAIRE	75-77
XI.1. Rein	75
XI.1.1. Néphrectomie	75
XI.1.2. Hématurie	75
XI.1.3. Insuffisance rénale	75
XI.1.4. Transplantation rénale	75
XI.1.5. Traumatisme rénal	75
XI.1.6. Hypertension secondaire à une lésion rénale traumatique	75
XI.2. Bassinet-uretère	76
XI.2.1. Hydronéphrose	76
XI.2.2. Lithiase	76
XI.2.3. Séquelles de lésions urétérales	76
XI.3. Vessie et urètre	76
XI.3.1. Tumeur	76
XI.3.2. Infection	76
XI.3.3. Rétention	76
XI.3.4. Fistule	76
XI.3.5. Pollakiurie	76
XI.3.6. Entérocystoplastie	77
XI.3.7. Dysurie	77
XI.3.8. Rétrécissement	77
XI.4. Eventration	77
XII. APPAREIL GENITAL	78-78
XII.1. Appareil génital masculin	78
XII.2. Appareil génital féminin	78
XIII. GLANDES ENDOCRINES	79-79
XIII.1. Séquelles hypophysaires	79
XIII.2. Séquelles surrénaliennes	79
XIII.3. Séquelles thyroïdiennes	79
XIII.4. Séquelles parathyroïdiennes	79
XIII.5. Séquelles du pancréas endocrine	79
XIV. TEGUMENTS	80-81
XIV.1. Cicatrices	80
XIV.1.1. Cicatrices du cuir chevelu, perte des cheveux	80
XIV.1.2. Cicatrices disgracieuses du visage gênant la mimique	80
XIV.1.3. Cicatrices des mains	80
XIV.1.4. Cicatrices vicieuses et chéloïdes	80
XIV.1.5. Cicatrices de la paroi abdominale	80
XIV.2. Tétanos	80
XIV.3. Cancer se développant sur une cicatrice	81
XIV.4. Dermo-épidermite	81
XIV.5. Fistules à la peau	81
XV. BIBLIOGRAPHIE	82

FIGURES

n° de figure	titres	pages
Fig 1	Pertes de segments de membres (sites d'amputation du membre supérieur)	18
Fig 2	Angles de raideur de l'épaule de profil avec taux indicatif	22
Fig 3	Angles de raideur de l'épaule de face avec taux indicatif	22
Fig 4	Angles de flexion - extension des raideurs du coude	23
Fig 5	Angles des raideurs du coude et du poignet	23
Fig 6	Schema indicatif des os de la main	25
Fig 7	Pouce	26
Fig 8	Index	26
Fig 9	Médus	27
Fig 10	Auriculaire et annulaire	27
Fig 11	perte d'un doigt	27
Fig 11	perte de deux doigts	27
Fig 11	perte de trois doigts	28
Fig 11	perte de quatre et de cinq doigts	28
Fig 11	perte de segments de doigts	28
Fig 12	Perte de segments de membres inferieurs (sites d'amputations)	34
Fig 13	schéma indicatif des os du pied	34
Fig 14	amplitudes articulaires du membre inferieur	40

GLOSSAIRE

termes	
Extrémité inférieure d'un membre	Extrémité distale
Extrémité supérieure d'un membre	Extrémité proximale
Tiers inférieur d'un membre	Tiers distal
Tiers supérieur d'un membre	Tiers proximal
membre supérieur	Membre thoracique
Brachial antérieur	Brachial
Court supinateur	Supinateur
Cubital antérieur	Fléchisseur ulnaire du carpe
Cubital postérieur	Extenseur ulnaire du carpe
Cubitus	ulna
Deuxième radial	Court extenseur radial du carpe
Fléchisseur commun profond des doigts	Fléchisseur commun des doigts
Fléchisseur commun superficiel des doigts	Fléchisseur superficiel des doigts
Fracture de Bennett	Fracture luxation de la base du 1 ^{er} métacarpien
Fracture de Rolando	Fracture de la base du 1 ^{er} métacarpien
Grand os	Os capitatum
Grand palmaire	Fléchisseur radial du carpe
Long supinateur	Brachio-radial
Nerf cubital	Nerf ulnaire
Omoplate	Scapula
Os scaphoïde carpien	Os naviculaire
Os semi lunaire	Lunatum
Périarthrite scapulo-humérale	Lésion des tendons de la coiffe des rotateurs
Petit palmaire	Long palmaire
Premier radial	Long extenseur radial du carpe
Sous épineux	Infra-épineux
Sous scapulaire	Sub scapulaire
Styloïde cubitale	Styloïde ulnaire
Sus épineux	Supra-épineux
Syndrome de Volkman	Syndrome des loges des membres
membre inférieur	Membre pelvien
Aileron rotulien	Rétinaculum patellaire
Arnoldalgie : névralgie d'Arnold Névralgie du grand occipital	Neuropathie périphérique du cou et de la tête caractérisée par une céphalée paroxystique unilatérale d'origine cervicale causée par une irritation ou une compression du grand nerf occipital postérieur et ou du petit nerf.
Calcanéum	calcanéus
Court péronier latéral	Court fibulaire
Demi-membraneux	Semi-membraneux
Demi-tendineux	Semi-tendineux
Extenseur commun des orteils	Long extenseur des orteils
Extenseur propre du gros orteil	Extenseur propre de l'hallux
Fléchisseur commun des orteils	Long fléchisseur des orteils
Gros orteil	Hallux
Jambier antérieur	Tibial antérieur
Jambier postérieur	Tibial postérieur
Jumeaux interne et externe	Gastrocnémien
Long fléchisseur du gros orteil	Long fléchisseur de l'hallux
Long péronier latéral	Long fibulaire
Malléole externe	Malléole latérale
Malléole interne	Malléole médiale
Nerf sciatique poplité externe	Nerf fibulaire commun
Nerf sciatique poplité interne	Nerf tibial
Péroné	Fibula
Rotule	Patella
Tendon d'Achille	Tendon calcanéen
Tendon rotulien	Ligament patellaire
Tibio-tarsienne	Tibio-talienne

PREAMBULE

La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), vingt-cinq (25) ans après sa création en 1993, regroupe actuellement dix-sept (17) Etats membres et 26 organismes de prévoyance sociale. Sa vocation essentielle est l'amélioration de la gouvernance des organismes de prévoyance sociale des Etats membres, la promotion et l'extension de la protection sociale aux populations. Elle s'est fixée également comme objectif la réalisation d'études et l'élaboration d'outils juridiques tendant à l'harmonisation de la réglementation applicable aux organismes et régimes de prévoyance sociale.

Ce barème de référence, premier du genre élaboré par la CIPRES en est une illustration. Sa mise en place résulte des constats de diverses insuffisances relevées dans le cadre juridique des régimes ou branches des risques professionnels, notamment les conditions de prise en charge et l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ou totale des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein des Etats membres de la zone CIPRES.

A cet effet, un Comité restreint d'Experts constitué des Inspecteurs du Travail relevant de la tutelle, des Médecins-Conseil, des Médecins du Travail et des Responsables en charge de la gestion des risques professionnels au sein des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) des Etats membres de la CIPRES a été mis en place. Sous la supervision du Secrétaire Exécutif de la CIPRES, Monsieur **Innocent MAKOUMBOU**, ce comité a été chargé d'élaborer la liste actualisée des maladies professionnelles ainsi que le barème de référence pour l'indemnisation des séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles harmonisés de la zone CIPRES.

A l'issue d'un processus laborieux, le projet de barème de référence a été adopté par le Conseil des Ministres de tutelle de la prévoyance sociale des Etats membres de la CIPRES lors de la 26ème session ordinaire tenue à Genève (Suisse), en juin 2018, en marge des Assemblées annuelles de l'OIT.

Ce barème s'est inspiré des textes internationaux en la matière notamment, de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et prend en compte les travaux déjà réalisés à travers certains barèmes existants tels que MAYET et REY, PADOVANI, ainsi que celui de l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS) de France.

La **Décision n° 521/CM/CIPRES du 1er juin 2018** a été pris à cet effet pour son application effective dans les Etats membres de la Conférence.

Il constitue l'expression de l'engagement des Etats membres de la CIPRES d'harmoniser les outils de base de gestion des risques professionnels, notamment la prise en charge des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP).

A l'instar des autres barèmes, il reste entendu que les taux indiqués ici ne peuvent être qu'indicatifs ; car le barème sert avant tout, de référence pour la fixation du taux de base, l'évaluation du Médecin sera toujours liée aux degrés de gravité de la séquelle, de l'importance des conséquences de voisinage du traumatisme, etc. dans ce cas le Médecin a l'obligation de motiver sa décision.

Comme toute œuvre humaine, cet outil est perfectible et nous restons ouverts aux contributions pertinentes éventuelles de tous en vue de son renforcement.

La CIPRES remercie tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage, à divers titres ; il s'agit notamment de :

- Docteur BABYLAS NDIAYE Marième Marianne, Médecin-Conseil National de la Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal ;
- Docteur TOURE Abou Médecin-Conseil National de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d'Ivoire ;
- Docteur ELLA ASSA Christiane Yvonne, Directeur Général Adjoint de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Gabon ;
- Docteur HAÏDARA Alpha Youssouf, Médecin-Conseil de l'Institut National de Prévoyance Sociale du Mali ;
- Docteur WAMBA Guillaume, Médecin-Conseil National de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Cameroun ;
- Docteur BADJINA MOUDOUA Firmine, Médecin-Conseil de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Gabon ;
- Docteur MATALI Edgard, Médecin-Conseil de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Congo ;
- Docteur AWUME Komi Edem, Médecin-Conseil de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Togo ;
- Docteur FAYE LABO Rokhaya, Médecin-Conseil de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger ;
- Messieurs :*
- DAGA Jean Versir, Directeur des Prestations de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Benin ;
- NGOMO MENIE Romaric, Directeur des Prestations Techniques de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Gabon
- SORRO Rodrigue José, Chef de service des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Centrafrique;
- ZOUNGRANA Martin, Ingénieur Sécurité et Hygiène Industrielles, Inspecteur du Travail de la Direction Générale de la Protection Sociale du Burkina Faso;

Pour le compte du Secrétariat Exécutif de la CIPRES, les Inspecteurs Régionaux:

Madame :

- OUATTARA ADJARATOU Djiré ;

Messieurs :

- SYNG YABE Barnabas ;
- MBAMA Fidèle ;
- NGUEBEMANDJI Robert.

INTRODUCTION

Ce barème de référence d'indemnisation des séquelles des accidents du travail et maladies professionnelles harmonisé répond à un des objectifs fixés dans le traité instituant la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale, celui de réaliser des études et d'élaborer des propositions relatives à l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes et aux régimes de prévoyance sociale.

Il a pour vocation l'évaluation des séquelles des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles (AT/MP) en vue de la réparation.

A cet effet, la recommandation n° 25 de la CIPRES adoptée en février 2005 indique à son article 147, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé notamment, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales sur la base **d'un barème d'invalidité commun aux Etats membres**.

L'adoption de ce barème de référence harmonisé vient combler un vide et de nombreuses insuffisances préjudiciables aux assurés sociaux en général et aux victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles en particulier, constatées dans les Etats membres.

Ce barème est mis à la disposition des médecins particulièrement des médecins conseils des organismes de prévoyance sociale mais aussi de tous les acteurs chargés de l'évaluation des séquelles et/ou de la réparation juridique du dommage corporel.

L'incapacité permanente est exprimée par un taux (dit **Taux d'Incapacité Permanente**) dont la gradation va de 0 à 100%. Elle peut être soit partielle (on parle alors **d'I.P. P**), soit totale ou définitive (**I.P.T.**). Elle peut faire l'objet d'une **révision** en cas de modification de l'état de la victime en aggravation ou en amélioration.

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le barème de référence CIPRES malgré les apports et innovations qu'il apporte ainsi que les espoirs qu'il suscite notamment, auprès des assurés, ne présente malgré tout qu'un caractère indicatif.

Les taux d'incapacité proposés sont en général des taux **moyens** que les médecins voudront bien appliquer dans la limite du possible. Par conséquent, devant un cas présentant des particularités, le médecin dispose de la faculté de s'écarter des taux du barème. Dans ce cas, il est alors dans l'obligation de fournir les arguments ou motivations qui l'ont conduit à fixer un taux autre que celui du barème de référence.

Toutefois, avant de proposer le taux d'incapacité permanente de la victime, le Médecin doit tenir compte de cinq éléments :

- La nature de l'infirmité ;
- l'état général ;
- l'âge ;
- les facultés physiques et mentales;
- les aptitudes et la qualification professionnelle.

Le Médecin doit également tenir compte de l'état antérieur de la victime.

1. La nature de l'infirmité

Elle représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de la validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain.

Le présent barème sert à cette évaluation.

La nature de l'infirmité constitue la donnée de base d'où le Médecin partira, en y apportant les correctifs en plus ou en moins, résultant des autres éléments.

2. L'état général

Le Médecin chargé de l'évaluation doit adapter le taux résultant de l'infirmité en fonction de l'**état général**.

Il n'est pas tenu compte dans l'estimation de l'état général des infirmités antérieures qu'elles soient consécutives à un Accident du Travail ou à une Maladie Professionnelle. Il en sera tenu compte lors du calcul du Taux Médical.

3. L'âge

On peut être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel et aux possibilités de cicatrisation.

4. Facultés physiques et mentales

Les taux proposés dans le présent barème concernent le sujet normal, il y'a lieu de les majorer si l'état physique ou mental de la victime paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un sujet normal.

5. Aptitudes et qualification professionnelle :

Cet élément est d'ordre **médico-social**.

Lorsque le Médecin chargé de l'évaluation estime que les séquelles de l'Accident du Travail ou de la Maladie Professionnelle sont susceptibles d'entraîner une modification dans la vie professionnelle de la victime ou un changement d'emploi, il lui appartient de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation.

II. METHODE DU CALCUL DU TAUX D'INCAPACITE

La **consolidation** est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, **la lésion se fixe et prend un caractère définitif**, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour prévenir une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'**Incapacité Permanente** consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de **révisions** possibles.

La **guérison**, ou reprise de l'état antérieur à l'accident à l'inverse, ne laisse subsister **aucune séquelle fonctionnelle**, donc **aucune incapacité permanente**.

II.1. Séquelles résultant de lésions isolées

Ces séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales ainsi que les aptitudes et qualifications professionnelles.

II.2. Infirmités multiples résultant d'un même accident

Il s'agit d'infirmités intéressant des membres ou des organes différents.

Lorsque les lésions portant sur **des membres différents** intéressent une **même fonction**, les taux estimés doivent en principe s'ajouter sauf certains cas mentionnés au barème.

Pour des **infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction**, il y a lieu d'estimer en premier lieu, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représentent la capacité totale) : on obtient ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle, puis rapportée à la capacité restante : **Méthode de Balthazar**.

Exemple : un même accident occasionne à deux fonctions différentes des taux respectifs de **10** et **20** %

Le taux global sera : $10 + \frac{20 \times (100 - 10)}{100} = 10 + 18 = 28\%$

Cette manière de calculer l'incapacité globale résultant de lésions multiples ne présente qu'un caractère indicatif. Le médecin chargé de l'évaluation peut toujours y apporter des rectificatifs ou adopter une autre méthode de calcul à condition de justifier son évaluation.

II.3. Infirmités antérieures

L'évaluation médicale de l'incapacité doit faire **la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident**. Les séquelles imputables à ce dernier sont seules en principes indemnissables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

- a. Un état pathologique antérieur asymptomatique peut être révélé à l'occasion de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, sans qu'il soit aggravé par les séquelles. Il n'en sera pas tenu compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
- b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler et aggraver un état pathologique antérieur. Il faut alors **indemniser totalement l'aggravation** consécutive au traumatisme.
- c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que son état était connu, il est possible d'en **faire l'estimation**.

III. REVISIONS

En dehors des cas où les séquelles présentent dès le départ un caractère définitif, l'état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical soit chirurgical ou l'appareillage.

Il peut être alors indiqué de procéder à des révisions périodiques selon la nature des séquelles.

BAREME DE REFERENCE HARMONISE

I. MEMBRE SUPERIEUR

Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.

La détermination de l'hémisphère cérébral dominant n'est pas toujours aisée. Cette recherche se fera sur la base de l'étude de la préférence gestuelle : manuelle, podale ou oculaire qui permettra de déterminer le caractère droitier ou gaucher ou ambidextre du sujet examiné.

L'ambidextrie professionnelle est la règle chez les travailleurs du bois : menuisiers, ébénistes...

I.1. Membre supérieur à l'exclusion de la main

I.1.1. Amputations

		Dominant	Non dominant
Epaule	- Amputation interscapulothoracique	95	85
	- Désarticulation de l'épaule	90 à 95	80 à 85
Bras	- Amputation des deux (2) bras	100	100
	- Au tiers supérieur	85 à 95	80
	- Au tiers moyen ou inférieur	80 à 90	70 à 80
	- Désarticulation du coude	80 à 90	70 à 80
Avant-bras	- Amputation des deux (2) avant-bras	100	100
	- Amputation d'un avant-bras tiers supérieur,	75	65
	- Amputation d'un avant-bras tiers moyen	70	60
	- Amputation d'un avant-bras tiers inférieur	70	60

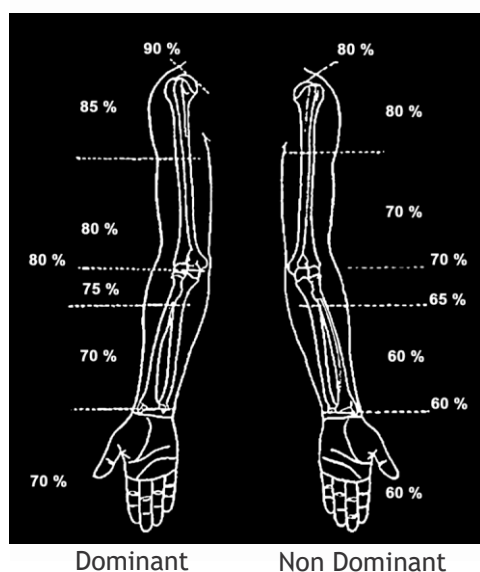


fig.1 : pertes de segments de membres (sites d'amputation du membre supérieur)

I.1.2. Fractures et luxations

		Dominant	Non dominant
Omoplate	Fracture omoplate		
	- Séquelles légères : gêne mouvement d'élévation du bras, douleur	15	10
	- Séquelles moyennes : raideurs articulaires, limitation mouvements du bras, arthrite	20 à 25	15 à 20
	- Séquelles graves : immobilisation ou ankylose	45 à 50	35 à 40
	Epaule (voir atteinte des fonctions articulaires)		
Clavicule	Fracture clavicule		
	- Séquelles minimes : fracture consolidée sans raideur	2 à 3	1 à 2
	- Séquelles légères : déformation, douleurs, gêne légère des mouvements de l'épaule	5 à 15	4 à 12
	- Séquelles moyennes : périarthrite avec raideur, cal saillant, douleurs	10 à 30	8 à 25
	- Séquelles graves : cal difforme comprimant le plexus (voir Nerfs)	30 à 40	25 à 35
	Luxation sternoclaviculaire		
	Gene fonctionnelle, suite de luxation interne	8 à 10	6 à 8
Humérus	Luxation acromio-claviculaire		
	La disjonction se trouve compliquée de périarthrite de l'épaule à évaluer séparément	4	3
	Luxation épaule (voir atteintes articulaires)		
	Fracture humérus		
	- Séquelles banales	10	8
	- Séquelles importantes avec désaxage, angulation, cal vicieux, raccourcissement de +4 cm	12 à 30	10 à 25
	Toute paralysie associée augmenterait le taux		
	- La paralysie totale du membre supérieur	70 à 80	60 à 70
Coude	Fracture et luxation du coude		
	Concerne l'extrémité inférieure de l'humérus et l'extrémité supérieure du radius (voir atteintes articulaires et pseudarthroses)		

		Dominant	Non dominant
Avant-bras	Fracture des 2 os de l'avant-bras		
	- Séquelles minimes avec bonne consolidation	5	4
	- Séquelles légères avec limitation pronation ou supination	15	12
	- Séquelles moyennes : limitation de la prono-supination	30	25
	- Séquelles graves : cal angulaire, raccourcissement, blocage de la prono-supination.....	35	28
Poignet	Fracture du cubitus		
	- Fracture olécrane	3 à 25	2 à 20
	- Fracture diaphysaire du cubitus	4 à 12	3 à 10
	- Fracture de la styloïde cubitale	0 à 5	0 à 3
	- Fracture de Monteggia	15 à 30	10 à 25
	Fracture du radius		
	Selon la prono-supination et la flexion extension des doigts		
	- Fracture cupule radiale	10 à 20	8 à 15
	- Fracture diaphysaire du radius	3 à 15	2 à 12
	- Fracture extrémité inférieure radius		
	• Séquelles légères	5 à 10	4 à 8
	• Séquelles moyennes	15 à 20	12 à 16
	• Séquelles graves : amyotrophie, limitation des mouvements poignet et doigts, déformation	20 à 30	18 à 25
	- Fracture de la styloïde radiale	0 à 5	0 à 4
	Os du carpe		
	- Fracture luxation du semi-lunaire	8 à 20	6 à 15
	- Fracture du scaphoïde carpien	6 à 20	5 à 15
	- Luxation du semi-lunaire et du grand os	20 à 25	15 à 25
	- Ostéoporose post traumatique-neuroalgodystrophie	10 à 25	8 à 20

I.1.3. Atteinte des fonctions articulaires

		Dominant	Non dominant
Epaule	- Blocage de l'épaule, omoplate bloquée	45 à 60	35 à 50
	- Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile	35 à 45	25 à 30
	- Limitation moyenne de tous les mouvements	20	15
	- Limitation légère de tous les mouvements	10 à 15	8 à 12
	- Périarthrite douloureuse aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera	5	5
	- Formes graves de luxation récidivante de l'épaule avec récurrences fréquentes	30	24
	- Formes moyennes de luxation récidivante de l'épaule avec récurrences espacées	20	15
	- Formes légères de luxation de l'épaule	15	10
	- Blocage de la flexion-extension :		
Coude	Angle favorable	25	22
	Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) ...	40	35
	- Limitation des mouvements de flexion-extension :		
	Mouvements conservés de 70° à 145°	10	8
	Mouvements conservés autour de l'angle favorable	20	15
Poignet	Mouvements conservés de 0° à 70° (cf.Fig.4)	25	22
	*Blocage du poignet :		
	- en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono- supination	15	10
	- en flexion sans troubles importants de la prono-supination	35	30
	*Limitation de la prono-supination en fonction de la position et de l'importance	10 à 15	8 à 12
	(ces 2 taux s'ajoutent aux taux précédents).		

LIMITATION DES MOUVEMENTS ARTICULAIRES DU MEMBRE SUPERIEUR

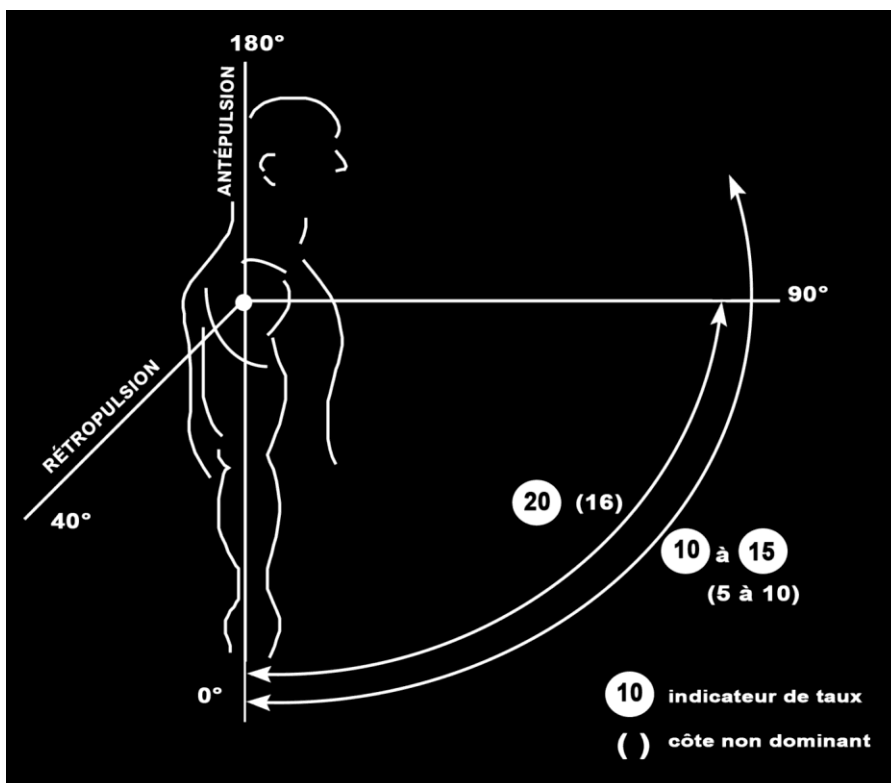


fig.2 : angles de raideur de l'épaule de profil avec taux indicatif

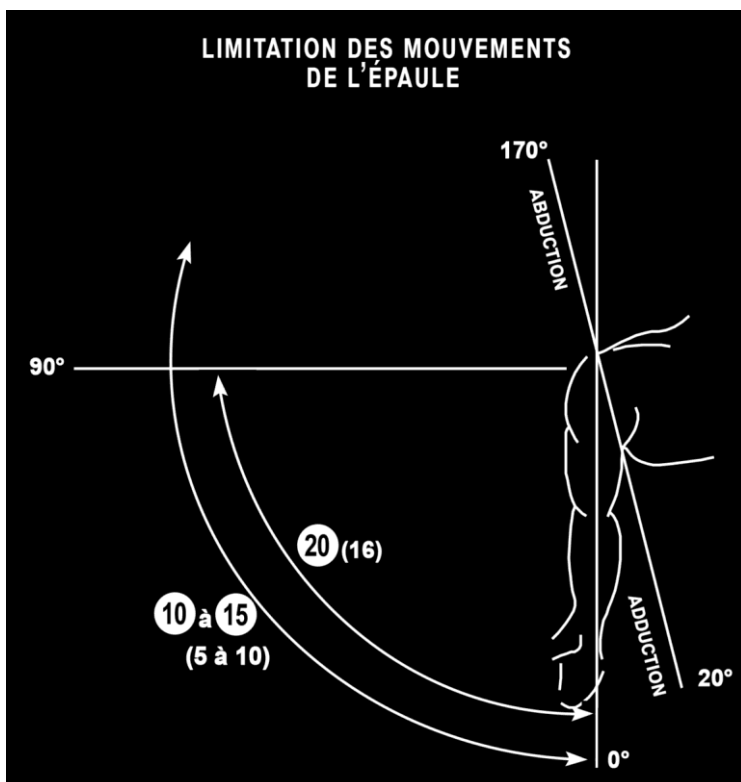


fig.3 : angles de raideur de l'épaule de face avec taux indicatif

LIMITATION DES MOUVEMENTS ARTICULAIRES DU MEMBRE SUPERIEUR

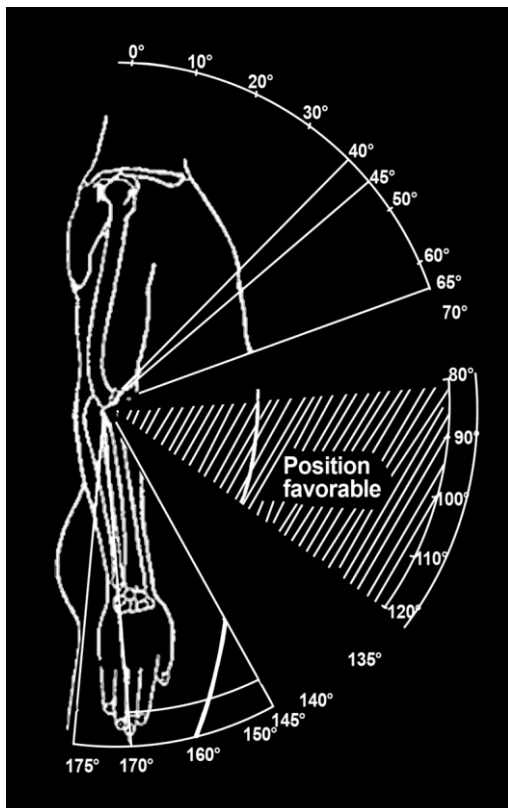


fig.4 : angles de flexion - extension des raideurs du coude

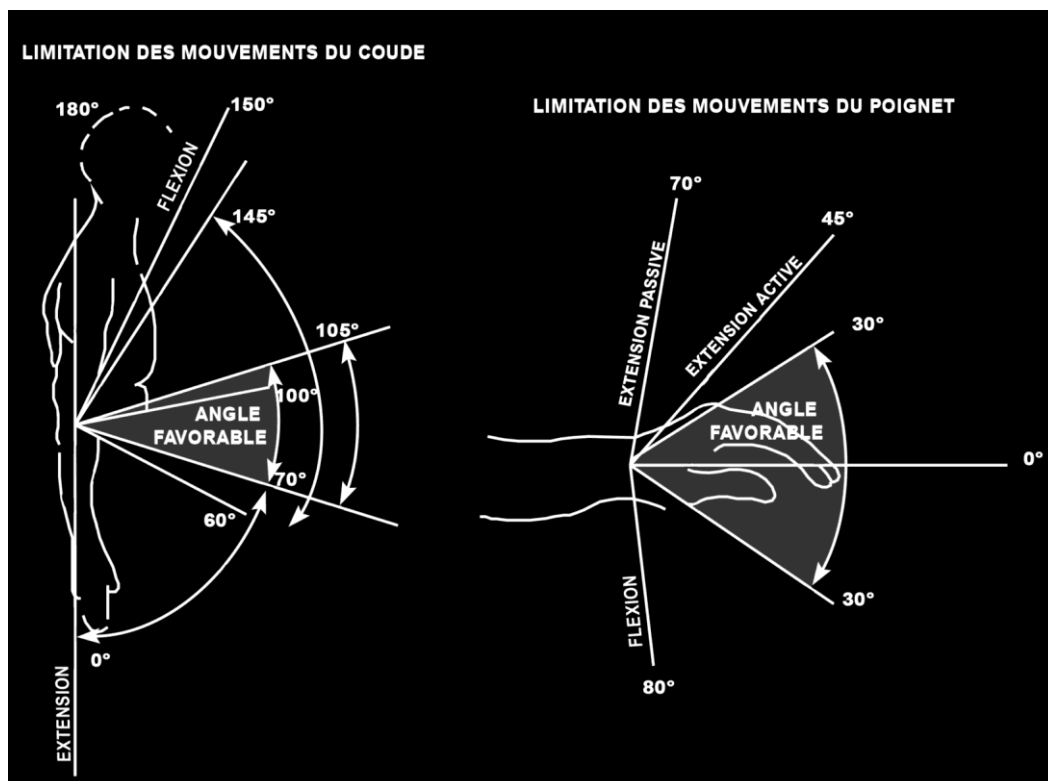


fig.5 : angles des raideurs du coude et du poignet

I.1.4. Pseudarthroses et déformations

		Dominant	Non dominant
Clavicule	- Cal difforme, sans compression nerveuse, selon gêne fonctionnelle	2 à 5	1 à 3
	- Compression nerveuse (voir séquelles portant sur le système nerveux périphérique)		
Epaule	- Pseudarthrose	5	3
	Epaule ballante consécutive à des pertes de substance osseuse étendues, sans séquelles nerveuses, autres que celles conditionnant le ballant de l'épaule	70	60
Bras	- Déformation du bras avec atrophie musculaire (taux s'ajoutant aux séquelles articulaires, nerveuses, etc. éventuellement associées)	5 à 10	4 à 8
	- Pseudarthroses de la diaphyse humérale :		
	Serrée	20	15
	Lâche.....	50	40
	-Raccourcissement important (supérieur à 4 centimètres) consécutif à de larges pertes de substance osseuse	5 à 10	4 à 8
Coude	- Coude mobile en tous sens, extension active nulle	30 à 40	25 à 30
	- Coude ballant, consécutif à des pertes de substance osseuse	50 à 55	40 à 45
	Les deux os :		
	- Pseudarthrose serrée	10 à 20	8 à 15
Avant-bras	- Pseudarthrose lâche (avant-bras ballant)	40 à 50	30 à 40
	Un seul os :		
	- Pseudarthrose serrée du radius	8 à 10	6 à 8
	- Pseudarthrose lâche du radius	30 à 40	25 à 30
	- Pseudarthrose serrée du cubitus	4 à 5	3 à 4
	- Pseudarthrose lâche du cubitus	25 à 30	15 à 20
Poignet	- Poignet ballant, à la suite de perte de substance du carpe	35 à 45	30 à 40
	- Main bote, radiale ou cubitale, consécutive à une large perte de substance d'un des os de l'avant-bras suivant le degré de la déviation latérale et de la gêne apportée à la mobilité des doigts	20 à 40	15 à 30

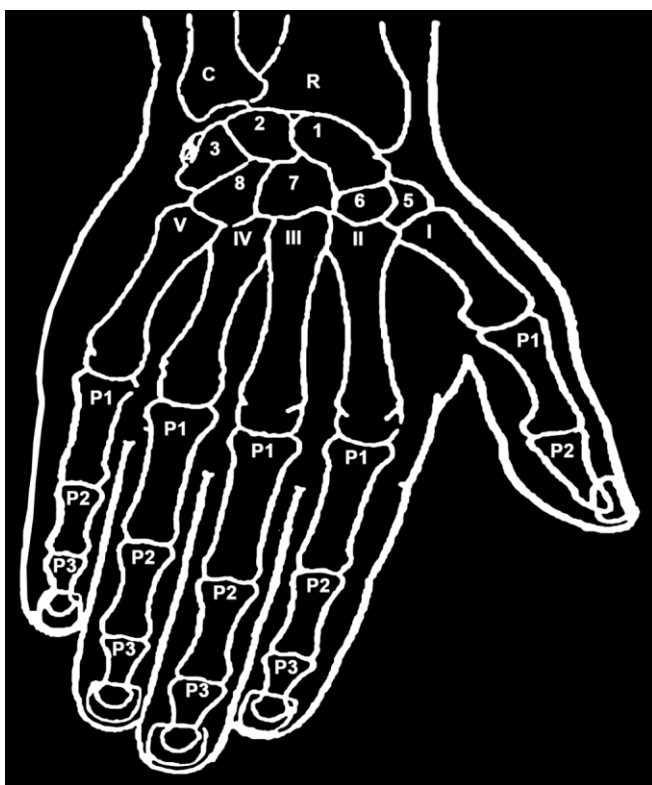


fig.6 : schéma indicatif des os de la main

R : radius ; C : cubitus ; 1 : scaphoïde ; 2 : semi-lunaire ; 3 : pyramidal ; 4 : pisiforme ; 5 : trapèze ; 6 : trapézoïde ; 7 : grand os ; 8 : os crochu ; I, II, III, IV, V : métacarpiens ; P1 : phalange proximale ; P2 : phalange intermédiaire ; P3 : phalange distale ou unguéale.

I.1.5. Séquelles musculaires et tendineuses

	Dominant	Non dominant
- Rupture du deltoïde	10 à 25	6 à 20
- Rupture du biceps (il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction et une diminution de la force) :		
• Séquelles légères	4	3
• Rupture de l'un des deux chefs non réparée	8 à 15	6 à 12
• Rupture complète de l'insertion inférieure non réparée ...	20 à 25	15 à 20
- Rupture du triceps partielle	10 à 20	8 à 15
- Rupture du triceps totale	20 à 30	15 à 25
- Syndrome de Volkman : selon l'importance de la répercussion sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques	30 à 70	25 à 60

I.2. La main

I.2.1. Amputations

		Dominant	Non dominant
	Perte totale de la main :		
Main	- Désarticulation du poignet ou amputation très basse de l'avant-bras	70	60
	- Désarticulation des cinq métacarpiens	70	60
	- Amputation intra-métacarpienne	70	60
	- Ablation du pouce et des quatre doigts	70	60
Pouce	- Perte du pouce avec le premier métacarpien	35	30
	- Perte de deux phalanges	28	24
	- Perte de la phalange unguéale	14	12
Index ou médius	- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)	14	12
	- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule	7	6
Annulaire	- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)	6	5
	- Deux phalanges ou la phalange unguéale	3	3
Auriculaire	- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)	8	7
	- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule	4	4

SITES D'AMPUTATION DES DOIGTS ET LEUR TAUX INDICATIF

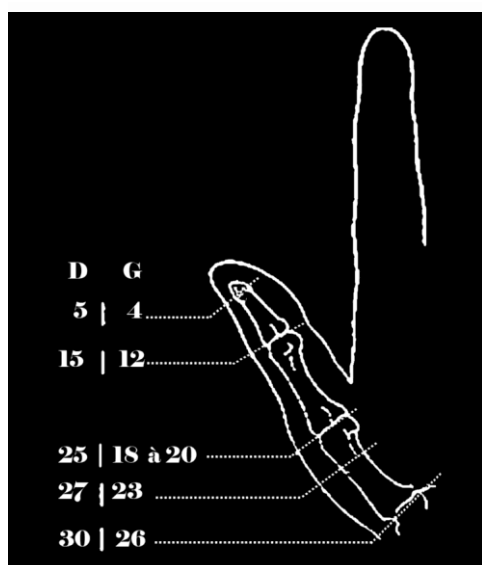


fig.7 : pouce

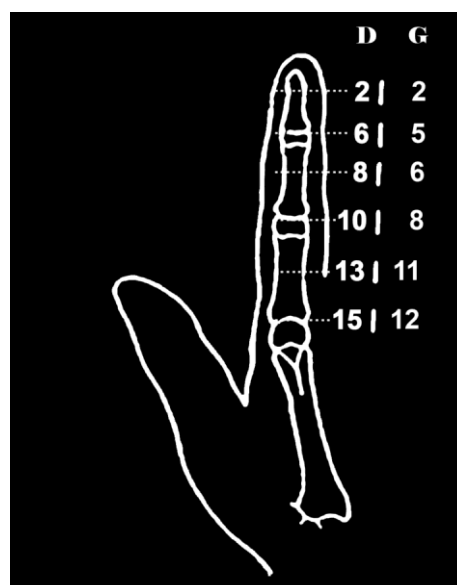


fig.8 : index

SITES D'AMPUTATION DES DOIGTS ET LEUR TAUX INDICATIF

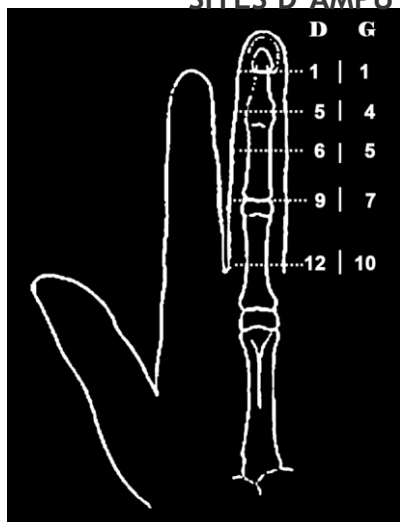


fig.9 : médus

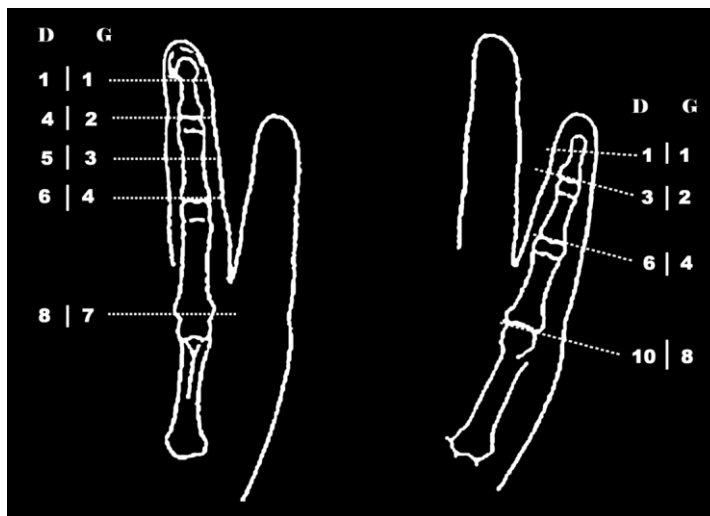


fig.10 : auriculaire et annulaire

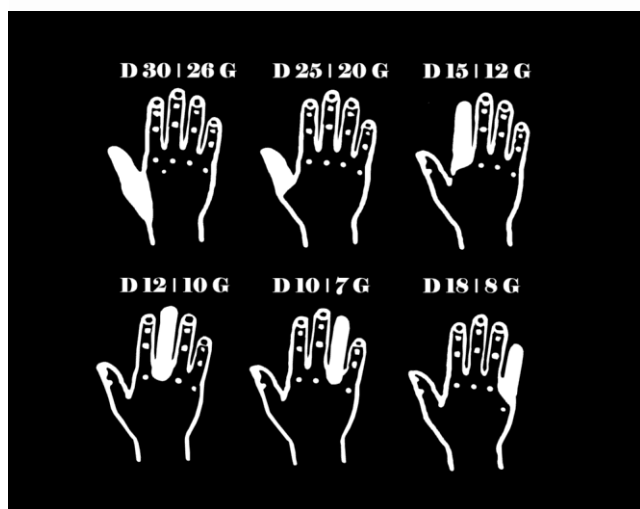


fig.11 : Perte de doigts – perte d'un doigt

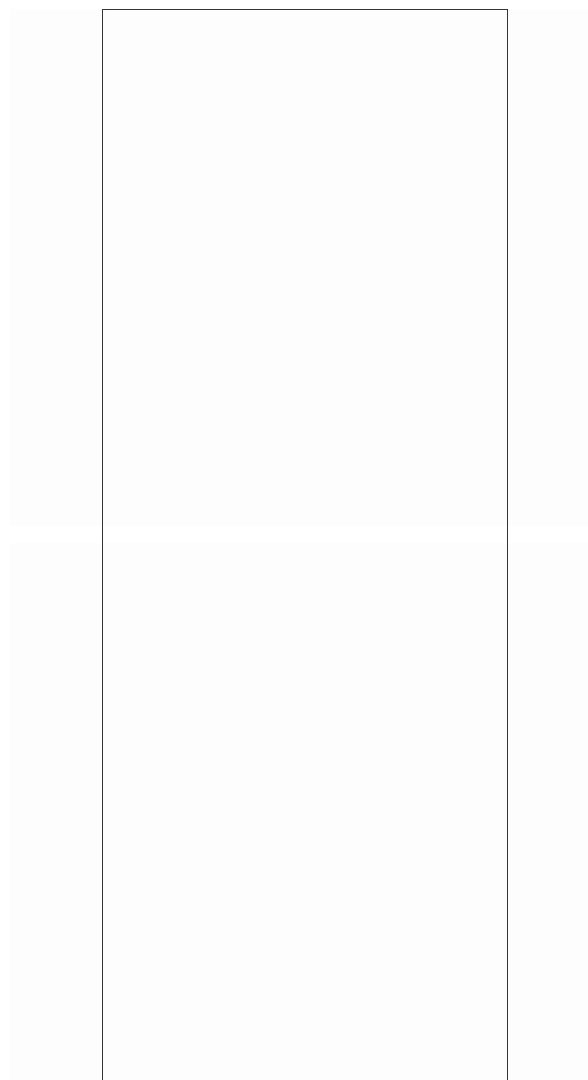


fig.11 : Perte de doigts – perte de deux doigts

SITES D'AMPUTATION DES DOIGTS ET LEUR TAUX INDICATIF

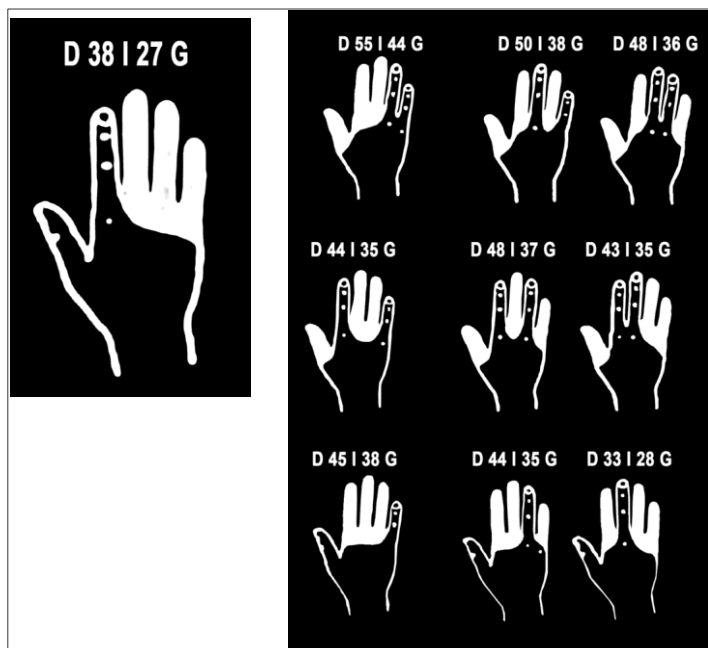


fig.11 : Perte de doigts – perte de trois doigts

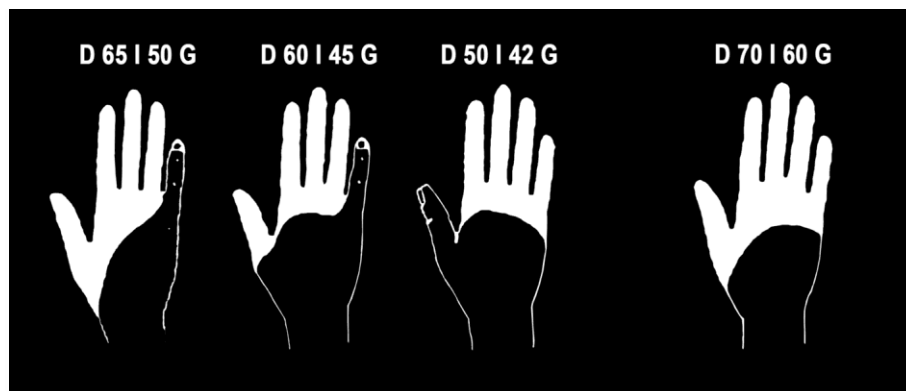


fig.11 : Perte de doigts – perte de quatre et de cinq doigts

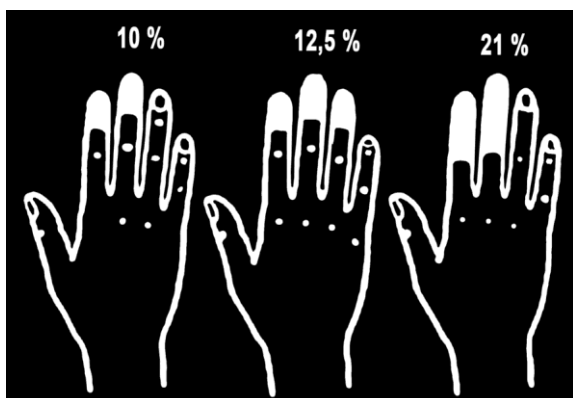


fig.11 : Perte de doigts – perte de segments de doigts

I.2.2. Fractures et luxations

		Dominant	Non dominant
Main	Fracture des métacarpiens		
	- M I selon la gêne de l'opposition du pouce	5 à 12	4 à 10
	- M II préhension douloureuse, cal saillant, retentissement sur les mouvements des doigts	10	8
	- M III	8	6
	- M IV, V	4	3
	- Fracture plusieurs métacarpiens	6 à 10	4 à 8
	- Fracture de Bennett	5 à 15	4 à 10
	Luxation des métacarpiens (Voir atteintes articulaires)		
	Fracture luxation des phalanges		
	Déformation, retentissement sur la mobilité des doigts, la préhension et la force de préhension (voir atteintes articulaires)	6 à 10	4 à 8

I.2.3. Atteinte des fonctions articulaires

		Dominant	Non dominant
Articulation carpo-métacarpienne	Perte de l'usage de la main par immobilisation de tous les doigts en extension ou en flexion ou incurvation	70	65
	L'atteinte de l'articulation carpo-métacarpienne est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du 1er espace interosseux et de la peau.		
	Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) :		
	- En position de fonction (antépulsion et opposition)	1 à 3	0 à 1
	- En position défavorable (adduction, rétropulsion)	1 à 4	0 à 3
	- Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce	4 à 8	3 à 6
	Les lésions du carpe proprement dit intéressant surtout sur le plan traumatique le semi lunaire et le scaphoïde.		

		Dominant	Non dominant
	Les besoins de l'articulation radio-lunaire retentissent directement sur la fonction du poignet et les lésions du scaphoïde carpien entraînent un retentissement fonctionnel sur mobilité de la colonne du pouce.		
	Raideurs articulaires plus ou moins serrées :		
Pouce	- Articulation métacarpo-phalangienne	1 à 3	0 à 1
	- Articulation inter-phalangienne	1 à 4	0 à 3
	- Articulation inter-phalangienne et métacarpo-phalangienne	4 à 8	3 à 6
Index	- Articulation métacarpo-phalangienne	1 à 2	0
	- Première ou deuxième articulation inter-phalangienne ...	1 à 5	0 à 4
	- Toutes les articulations (index raide)	5 à 10	4 à 8
Médus-annulaire	- Une seule articulation	0 à 2	0
	- Toutes les articulations	5 à 8	4 à 6
Auriculaire	- Une seule articulation	0 à 1	0
	- Toutes les articulations	2 à 5	0 à 4
Les quatre doigts avec le pouce libre	Suivant que la gêne fonctionnelle intéresse :		
	- L'extension	10 à 15	8 à 12
	- La flexion	20 à 30	15 à 20
Les quatre doigts et le pouce	Suivant que la gêne fonctionnelle intéresse :		
	- L'extension	10 à 20	8 à 15
	- La flexion	30 à 40	20 à 30
	Ankyloses complètes :		
Pouce	- Articulation carpo-métacarpienne	15 à 20	12 à 15
	- Articulation métacarpo-phalangienne	8 à 10	6 à 8
	- Articulation inter-phalangienne	5 à 6	4 à 5
	- Articulation métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne	15 à 18	12 à 14
	Toutes les articulations :		
	- Pouce en extension	25 à 30	20 à 25
	- Pouce en flexion modérée	20 à 25	15 à 20

		Dominant	Non dominant
Index	- Articulation métacarpo-phalangienne	4 à 5	3 à 4
	- Articulation de la première et de la deuxième phalange	8 à 10	6 à 8
	- Articulation de la deuxième et de la troisième phalange	2 à 3	0 à 1
	- Les deux dernières articulations	8 à 10	6 à 8
	- Les trois articulations	13 à 15	10 à 12
Médius	- Articulation métacarpo-phalangienne.....	3 à 4	1 à 2
	- Articulation de la première et de la deuxième phalange	6 à 7	4 à 5
	- Articulation de la deuxième et de la troisième phalange	1 à 2	0 à 1
	- Les deux dernières articulations	8 à 10	6 à 8
	- Les trois articulations	12 à 15	10 à 12
Annulaire	- Articulation métacarpo-phalangienne	2 à 3	0 à 1
	- Articulation de la première et de la deuxième phalange		
	- Articulation de la deuxième et de la troisième phalange	5 à 6	3 à 4
	- Les deux dernières articulations	1 à 2	0 à 1
	- Les deux dernières articulations	8 à 10	6 à 8
	- Les trois articulations	10 à 12	7 à 9
Auriculaire	- Articulation métacarpo-phalangienne	1 à 2	0 à 1
	- Articulation de la première et de la deuxième phalange	3 à 4	1 à 2
	- Articulation de la deuxième et de la troisième phalange	1 à 2	0 à 1
	- Les deux dernières articulations	5 à 6	3 à 4
	- Les trois articulations	8 à 10	6 à 8
Lésions multiples	La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions.		

I.2.4. Pseudarthroses et déformations

		Dominant	Non dominant
Métacarpien	- Cal saillant entraînant une gêne fonctionnelle	2 à 4	2 à 4
	- Pouce	5 à 6	4 à 5
Phalange unguéale	- Autres doigts	1 à 2	0 à 1
	- Pouce	14 à 16	11 à 13
	- Index	9 à 11	7 à 9
	- Autres doigts	4 à 6	3 à 5
Autres phalanges	Les pseudarthroses ou les cals vicieux des métacarpiens et des phalanges seront appréciés selon le retentissement sur le fonctionnement général de la main.		

I.3. Ostéite et ostéomyélite

Venant s'ajouter aux éléments séquellaires :

- Fistule persistante unique.....10
- Fistule persistante avec déformation osseuse10 à 25

II. MEMBRE INFÉRIEUR

II.1. Amputations

Hanche	* perte des deux membres inférieurs	100
	* amputation inter-ilio-abdominale	100
Cuisse	- Désarticulation de la hanche	100
	- Amputation inter-trochantérienne	100
	- Amputation sous-trochantérienne et tiers supérieur	95 à 100
	- Amputation au tiers moyen ou au tiers inférieur	70 à 80
Genou	- Désarticulation	70 à 75
Jambe	- Amputation au tiers supérieur	65 à 70
	- Amputation au tiers moyen ou au tiers inférieur	50 à 65
	- Amputation des deux jambes	100
Cheville	- Désarticulation tibio-tarsienne	50 à 55
Pied	- Amputation du pied, avec conservation de la partie postérieure du calcanéum avec bon appui talonnier (avec mouvement du pied restant satisfait et sans bascule en varus)	30 à 35
	- Désarticulation médio-tarsienne de Chopart	30 à 45
	- Amputation trans-métatarsienne de l'avant-pied (Lisfranc).....	30 à 35
Orteils	L'amputation d'orteils prend surtout de l'importance, lorsqu'il s'agit du 1er orteil , ou de plusieurs orteils voisins .	
	Perte de 5 orteils	20 à 30
	Hallux :	
	- Les deux phalanges avec le métatarsien	20
	- Les deux phalanges	12
	- Phalange distale	5
	Autres orteils :	
	- amputation d'un orteil	2
	- 2ème ou 5ème orteil avec leur métatarsien	10
	- 3ème ou 4ème orteil avec leur métatarsien	5
	L'incapacité résultant de la perte de plusieurs orteils sera évaluée en estimant la perte de chaque orteil séparément, et en faisant la somme. le taux global ne pourra dépasser le taux fixé pour l'amputation de tous les orteils.	

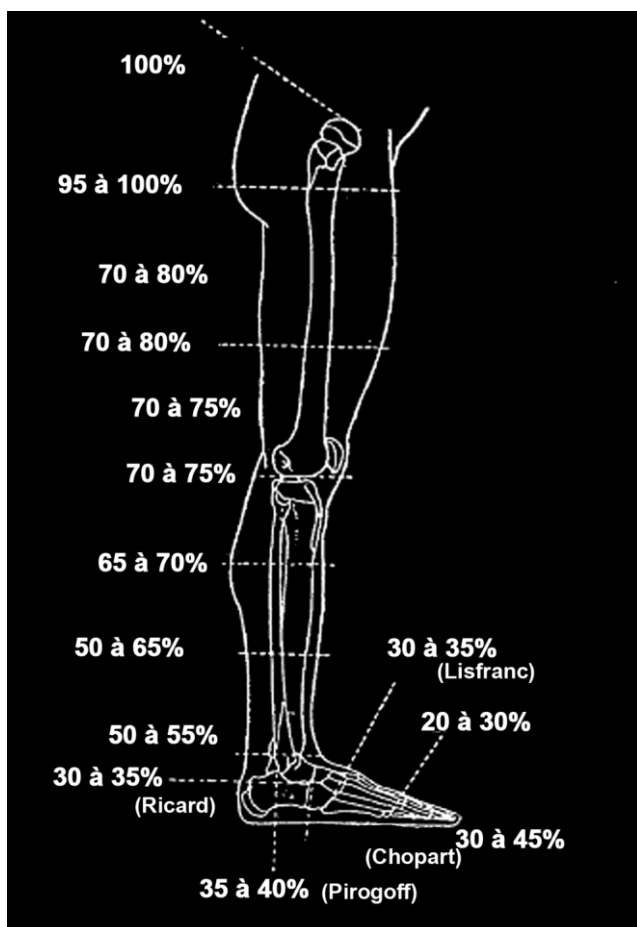


fig.12 : perte de segments de membres inférieurs (sites d'amputations)

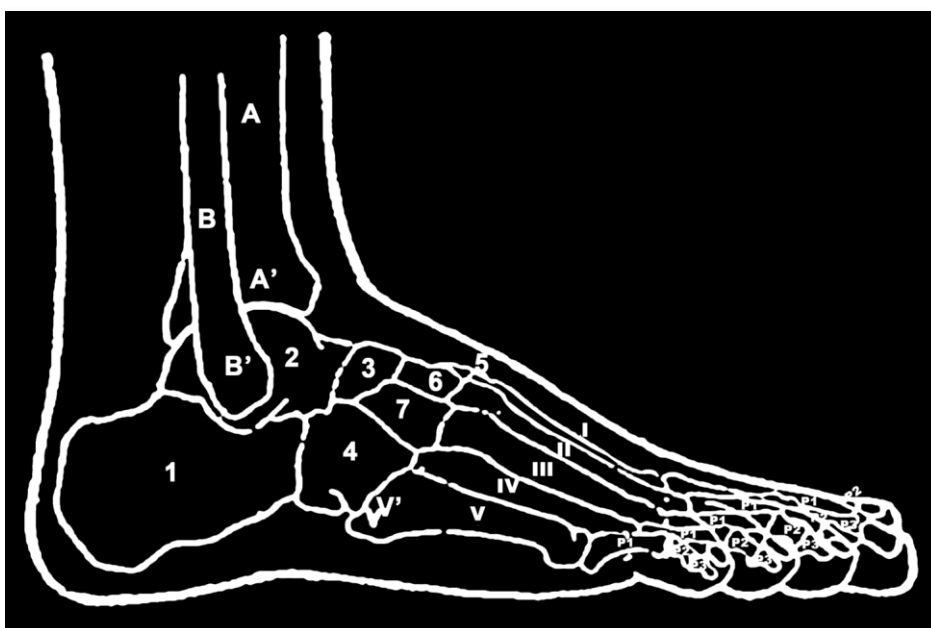


fig.13 : schéma indicatif des os du pied

A : tibia ; A' : malléole interne ; B : péroné ; B' : malléole externe ; 1 : calcanéum ; 2 : astragale ; 3 : scaphoïde ; 4 : cuboïde ; 5 : premier cunéiforme ; 6 : deuxième cunéiforme ; 7 : troisième cunéiforme ; I, II, III, IV, V : métatarsien ; V' : apophyse styloïde du V métatarsien ; P1 : phalange proximale ; P2 : phalange intermédiaire ; P3 : phalange distale.

II.2. Fractures et luxations

Hanche	Fractures, luxations, contusions séquelles à type de raideur ou ankylose (voir atteintes articulaires)	35 à 45
	Fracture du col du fémur	60 à 70
	Fracture du col	
	• Cas de très bon résultat anatomique	10
	• Cas d'un blessé d'une cinquantaine d'années avec limitation marquée des mouvements de la hanche	20
	• Cas d'un blessé de 60 ans et plus avec boiterie déformation et gêne articulaire marquée	65 à 70
Cuisse	Fracture de la diaphyse	
	- Ouvrier jeune, sans séquelles graves, raccourcissement ne dépassant pas 4 cm	5 à 8
	- Ouvrier âgé de 40-45 ans avec cal, douleurs, atrophie musculaire, raccourcissement ne dépassant pas 4 cm	10 à 15
	- Ouvrier de plus de 50 ans avec raideur articulaire, amyotrophie prononcée, cal difforme, angulation, raccourcissement de plus de 9 cm	20 à 25
	- Pseudarthrose	40 à 45
	Entorse Luxation (voir atteintes articulaires)	
Genou	Fracture de la rotule :	
	- Fracture parcellaire	10 à 15
	- Cal osseux ou fibreux court, bonne extension, flexion peu limitée	30 à 40
	- Cal fibreux long, extension active Complete, mais faible, flexion peu limitée	5 à 30
	- Cal fibreux long, extension active, presque nulle, atrophie notable de la cuisse	12
	- Fractures verticales	15 à 50
	Ablation de la rotule :	
	- avec genou libre, atrophie notable du quadriceps et limitation extension	5 à 15
	- combinée à des raideurs du genou	0 à 2

Jambe	• Séquelles légères :	
	Fracture des deux os de la jambe	
	Ouvrier jeune avec raccourcissement de moins de 4 cm	6 à 18
	• Séquelles moyennes :	
	Ouvrier de 40-50 ans avec raccourcissement de moins de 5 cm ...	25
	• Séquelles graves :	
	Ouvrier âgé avec raccourcissement de plus de 5 cm, retentissement articulaire, atrophie des muscles	40
	Fracture du tibia	
	• Fracture du plateau tibial	15 à 50
	• Fracture diaphyse tibiale	5 à 15
Cheville	Fracture du péroné	0 à 2
	Entorse (Voir atteintes articulaires)	
	Fracture bi malléolaire	0 à 15
	Fracture malléolaire	
	• Externe	3
	• Interne	5
	Luxations des métatarsiens et du tarse (voir Atteintes articulaires)	
	Fracture des métatarsiens	
	• 1er Métatarsien	3 à 20
	• 5ème métatarsien	7 à 15
Pied	• Métatarsien moyen	5 à 20
	Fracture du calcanéum	
	• Séquelles légères	5 à 8
	• Séquelles moyennes	3 à 5
	• Séquelles graves	12
	Fracture luxation orteils (Voir atteintes articulaires)	

II.3. Atteintes des fonctions articulaires

Symphyse pubienne	- Disjonction pubienne (selon le diastasis, la gêne à la marche, l'impossibilité des efforts, les douleurs éventuelles, compte non tenu des retentissements sacro-iliaques)	10 à 25
Articulations sacro-iliaques	- diastasis (entraînant une mobilité anormale du sacrum, avec retentissement sur la marche accroupissement impossible, sacralgies)	25 à 45
	- arthropathies sacro-iliaques douloureuses chroniques d'origine traumatique	15
Hanche	- blocage en rectitude (position la plus favorable)	50 à 55
	- blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction rotation)	65 à 70
	- blocage des deux hanches	90 à 100
	- Hanche ballante	75 à 80
	Limitation des amplitudes de la hanche	
	- mouvements favorables	8 à 20
	- Mouvements très limités	25 à 40
Genou	Blocage du genou	
	- Rectitude (position favorable)	30
	- De 5° à 25°	35
	- De 25° à 50°	40
	- De 50° à 80°	50
	- 80° et plus	60
	Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse	10 à 15
	Limitation des mouvements du genou :	
	- Déficit d'extension de 5° à 25°	5
	- Déficit d'extension de 25°	15
	- Déficit d'extension de 45°	30
	- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°	5
	- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 90°	15
	- La flexion ne peut se faire au-delà de 45°	25

	Mouvements anormaux - Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité, tiroir, etc.)..... - Blocage ou dérochement intermittent compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes paracliniques)	5 à 35 5 à 15
	*ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.	
Genou	- rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens)..... - luxation récidivante - patellectomie à ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.	10 15 5
	Hydarthrose chronique : - légère - moyenne - récidivante, entraînant une amyotrophie marquée Corps étrangers traumatiques (à évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés)	5 10 15 5 à 25
Cheville	Articulation tibio-tarsienne : - blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied - en bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied - blocage de la cheville, pied talus - blocage de la cheville, pied en équin prononcé Déviation en varus, en plus Déviation en valgus, en plus Limitation des mouvements de la cheville : - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autres de l'angle droit)..... - Diastasis tibio-péronier important en lui-même - Déviation en varus, en plus - Déviation en valgus, en plus	15 20 à 35 25 20 à 50 15 25 6 12 15 10

Pied	Articulations sous astragaliennes et tarso-métatarsiennes : Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu' à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans). - Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15 Les articulations métatarso- phalangiennes permettent aux orteils un angle de flexion-extension de 90° environ ; la plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui et de grasping dans la locomotion. Blocage isolé de cette seule articulation : - Gros orteil : En rectitude (bonne position) 2 à 5 En mauvaise position 10 à 12 - Autres orteils : En rectitude 0 à 15 En mauvaise position 5 à 15 Limitation de mouvements - Gros orteil 2 à 4 - Autres orteils 1 à 4 Articulation inter-phalangienne du gros orteil, seule, a une importance dans la fonction de locomotion. - Blocage de l'inter-phalangienne du gros orteil 3 - Limitation de ses mouvements 1	
------	--	--

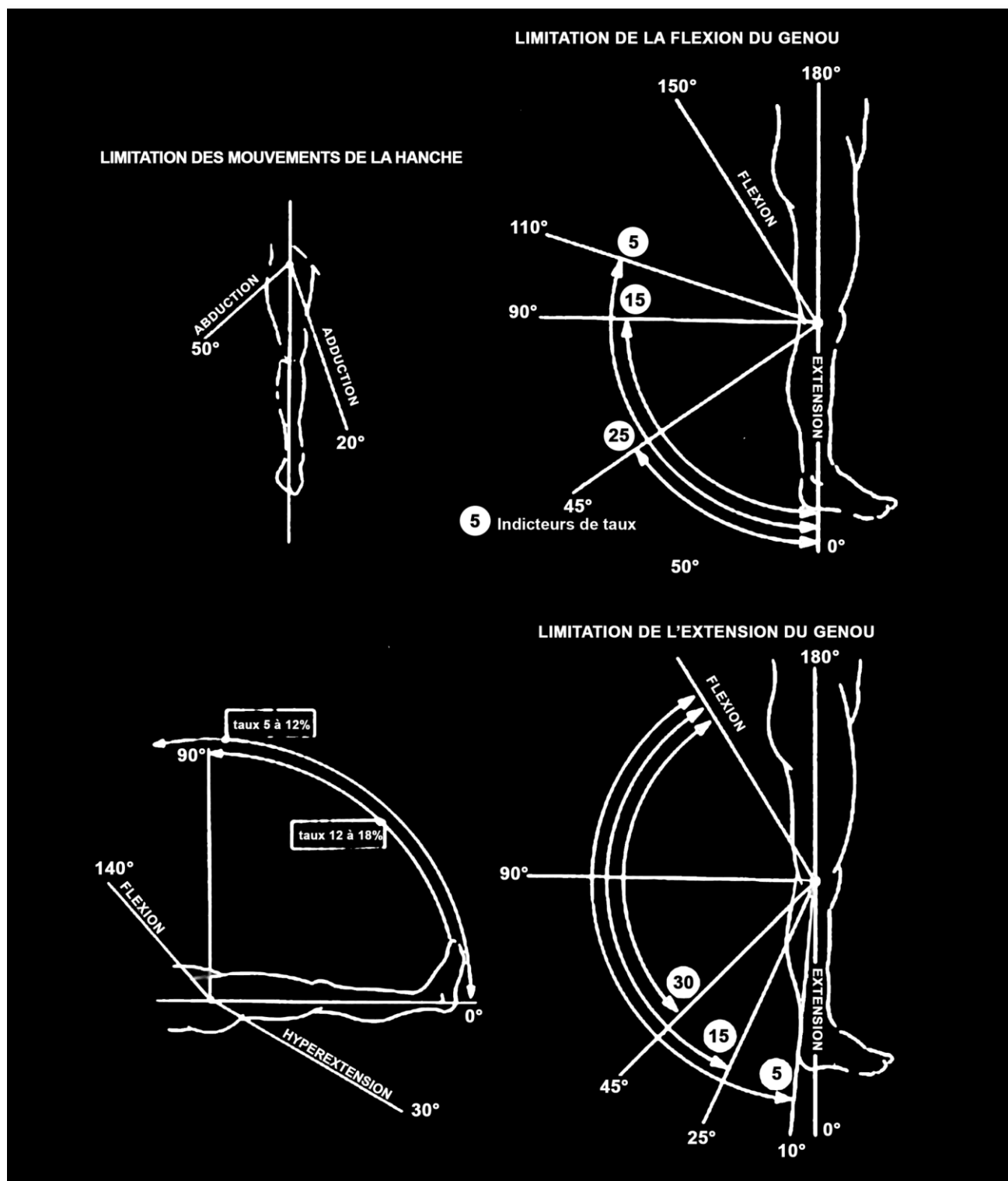


fig.14 : amplitudes articulaires du membre inférieur

II.4. Pseudarthroses, déformation et raccourcissements

Cuisse	- Angulation, déformation, selon le retentissement sur la marche	10 à 30
	- Pseudarthrose du fémur	60 à 70
Genou	- Pseudarthrose consécutive à une résection du genou	50 à 55
	- Genou ballant	60 à 65
Jambe	- Angulation, déformation en baïonnette, etc., selon le retentissement sur la marche	5 à 25
Pied	- Pseudarthrose du tibia ou des deux os	55 à 70
	- Affaissement de la voûte plantaire	5 à 15
	- Pied creux post-traumatique	5 à 10
	- Exostose sous-calcaneenne	15
	- Cal vicieux, exubérant. Selon répercussion sur la marche	5 à 15
Raccourcissements Le taux évalué pour le raccourcissement post-traumatique s'ajoutera aux autres taux ayant pu être éventuellement estimés par ailleurs pour d'autres séquelles. - Moins de 2 cm 0 - De 2 à 3 cm 4 - De 3 à 6 cm 15 - De 6 à 8 cm 22 - De 8 à 10 cm 30 - 10 cm et plus 40 Le raccourcissement sera toujours soigneusement mesuré entre repères osseux (par exemple : épine iliaque antéro-supérieure-malléole interne).		

II.5. Séquelles Musculaires et Tendineuses :

- Rupture musculaire complète (quadriceps, adducteurs, etc.)	10 à 15
- Maladie de Pellegrini Stieda (à évaluer selon les séquelles fonctionnelles). Rupture du tendon rotulien ou quadricipital :	
Non réparée	30
Réparée (à évaluer selon le déficit fonctionnel résiduel du genou).	
- Rupture d'un aileron rotulien, avec mobilité anormale de la rotule	15
- Rupture du tendon d'Achille :	
Non réparée	12 à 25
Réparée (à évaluer selon limitation des mouvements de la cheville et l'atrophie du mollet).	
- Rupture des péroniers latéraux (Complète/incomplète)	10 à 20
- Luxation des tendons péroniers :	
Non réparée	5 à 10
Réparée	0 à 5

II.6. Ostéites et ostéomyélites :

(venant s'ajouter aux autres éléments séquellaires)	
- Fistule persistante unique	10
- Fistule persistantes multiples, avec déformation osseuse résistant à la cure chirurgicale	15 à 25

III. RACHIS

III.1. Rachis Cervical

- Entorses, fractures, luxations sans atteinte nerveuse	10 à 40
- Fracture des apophyses transverses	5 à 25
Immobilisation partielle de la tête et du tronc (avec ou sans déviation):	
- Sans douleurs	1 à 15
- avec douleurs :	
Douleurs ostéo-articulaires	15 à 25
Douleurs névralgiques	20 à 40
- Immobilisation avec déviation très prononcée et en position très gênante	40 à 45
- Ankylose après traumatisme vertébral	20 à 80
- Fractures du rachis cervical sans lésion médullaire :	
Atlas, tassement	20
Rupture des arcs	50
Apophyse odontoïde de l'axis avec déplacement ou risque de glissement	50
Autres vertèbres	15 à 20
- fracture du rachis cervical avec troubles médullaires plus ou moins importants pouvant aller à la tétraplégie	60 à 100

III.2. Rachis Dorsolombaire

- cas léger (simple tassement vertébral sans raideur, sans signes neurologiques)	15
- Tassement vertébral avec raideur rachidienne nette sans signes neurologiques	20 à 30
- Fractures ou luxations avec raideurs rachidienne importante et signes d'irritation radiculo-médullaire légers	40 à 50
- Cas graves (paraplégie, troubles sphinctériens, troubles trophiques)	60 à 100
- Apophyses transverses	10 à 25
- Apophyse épineuse isolée	3 à 5
- Lumbago vrai post-traumatique :	
Légère raideur	0 à 10
Raideurs plus marquées	15 à 20
Raideurs très importantes	35
Avec signes radiculaires	35 à 50
Hernie discale avec sciatique :	
- Unilatérale	30 à 60
- Bilatérale	40 à 85
- Lombo-sacralgie par lésion discale	30

III.3. Sacrum et Coccyx

- Fracture de l'aileon	5 à 10
- Fracture verticale ou transversale simple	15 à 40
- Avec troubles sphinctériens et /ou génitaux	60 à 80
- Coccygodinie	5 à 20

IV. CRANE ET SYSTEME NERVEUX

IV.1. Séquelles osseuses

Embarrure crânienne persistante, selon le degré d'enfoncement :	
- ½ centimètre	2
- 1 centimètre	5
- Plus de 1 centimètre	10
Perte de substance osseuse (avec battements duremériens et impulsion à la toux) :	
- Diamètre : 3 centimètres	10 à 20
- De 4 à 9 centimètres	20 à 40
- 10 centimètres	40 à 60
Perte de substance réparée par plastie, mal tolérée : le taux sera apprécié selon l'importance des troubles fonctionnels. Les séquelles de trépanation ne donnent plus lieu en elles-mêmes à une indemnisation, même s'il y a quatre ou cinq trous de trépan, sauf cicatrices douloureuses.	
- Volet cicatrisé en mauvaise position	5 à 10
Corps étranger intracrânien : quand il entraîne des troubles fonctionnels, il convient de fixer le taux d'incapacité en fonction de ces troubles (hémiplégie, aphasie, troubles endocriniens ou neurologiques divers).	

IV.2. Séquelles portant sur le névraxe

Les incapacités résultant d'une atteinte du névraxe seront évaluées non pas à partir de la lésion initiale elle-même, mais en fonction des séquelles réduisant l'activité de l'intéressé.

L'examen neurologique clinique s'attachera à mettre en évidence :

*Les troubles moteurs

- Limitation totale ou partielle des mouvements volontaire ;
- Trouble du tonus ;
- Trouble des mouvements associés à la coordination ;
- Mouvements involontaires (tremblement, mouvements athétosiques ou choréiques, etc.) ;
- Akinésie ou dyskinésie ;
- Ataxie, etc.

***Les troubles sensitifs**

- Anesthésie ;
- Douleurs, dysesthésies ;
- Astéréognosie ;
- Perte du sens de position et atteinte de la sensibilité discriminative ;
- Paresthésies, etc.

L'examen clinique gagnera, le cas échéant, à s'appuyer sur des examens complémentaires : **électroencéphalogramme, examen ophtalmologique, examen oto-vestibulaire, examen neuroradiologique, échographie, tomodensitométrie, imagerie par résonnance magnétique, petscan, etc.**

IV.2.1. Séquelles propres au crâne et à l'encéphale**IV.2.1.1. Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne**

Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le « **syndrome subjectif** ». On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.

Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.

Lors de l'interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de « **diriger** » l'interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.

- **Syndrome subjectif post-commotionnel** **5 à 20**

On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : **bilans ophtalmologique et otorhinolaryngologique, électroencéphalogramme, tomodensitométrie, examen neuroradiologique, échographie, tomodensitométrie, imagerie par résonnance magnétique, petscan, etc.**

IV.2.1.2. Syndrome cervico-céphalique

Il s'accompagne éventuellement de vertiges de position avec obnubilation visuelle, « **arnoldalgie** », point d'ERB, contracture du trapèze, redressement de la lordose cervicale physiologique, limitation plus ou moins douloureuse de la mobilité du cou.

- **Syndrome isolé** **5 à 15**

- **Syndrome associé à un syndrome post-commotionnel, le taux global n'excédera pas** **25**

IV.2.1.3. Epilepsie

Les séquelles épileptiques seront chiffrées d'après la fréquence des crises, un traitement étant régulièrement suivi. La plupart des épilepsies peuvent en effet être équilibrées par une médication appropriée. Si les crises surviennent après la fin de la première année, la relation avec le traumatisme sera établie ou non, après un examen approfondi du blessé.

Le médecin chargé de l'évaluation prendra connaissance du traitement suivi et demandera dans tous les cas un électroencéphalogramme, s'il n'a pas déjà été pratiqué. Il demandera au besoin une hospitalisation pour contrôle.

Epilepsie généralisée	
- Epilepsie légère contrôlée par le traitement et compatible avec l'activité professionnelle habituelle	10 à 15
- Epilepsie mal contrôlée par le traitement avec crises fréquentes et éventuellement, troubles du comportement associé, nécessitant des précautions spéciales au travail (dans ce cas,) la nécessité d'un changement de profession ou de poste de travail doit être particulièrement mis en relief	30 à 70
- Epilepsie incontrôlée avec crises fréquentes nécessitant la surveillance du sujet et rendant impossible toute activité	100

Epilepsie focalisée (différents types d'épilepsies)	
Epilepsie bravais-jacksonienne	10 à 40
Epilepsie psychomotrice	10 à 60
Epilepsie frontale	10 à 40
Epilepsie occipitale	10 à 40
Epilepsie pariétale	10 à 40

IV.2.1.4. Syndromes parkinsoniens

Trois étiologies sont possibles :

- Lésion cérébrale par corps étranger touchant les noyaux gris centraux (exceptionnels) ;
- Traumatisme crano-cérébral ;
- Origine toxique (**oxyde de carbone, dioxyde de manganèse, etc.**).

Pour les trois formes, le taux tiendra compte de la gravité et du caractère unilatéral ou bilatéral :	
- Syndrome parkinsonien léger, réagissant bien au traitement	10 à 20
- Syndrome plus accentué, avec gêne appréciable	20 à 40
- Syndrome important	40 à 90
- Syndrome excluant toute possibilité d'activité	100

IV.2.1.5. Torticolis spasmodique post-traumatiques 10 à 20**IV.2.1.6. Tremblement volitionnel d'attitude post-traumatique, habituellement unilatéral**

Dominant 30 à 60

Non dominant 20 à 40

IV.2.1.7. Syndrome cérébelleux

Atteinte bilatérale :		
- Atteinte cérébelleuse globale incompatible avec une activité professionnelle		100
- Atteinte bilatérale mais incomplète		60 à 80
- Atteinte bilatérale légère avec marche perturbée et une certaine maladresse des mouvements		30 à 50
Atteinte unilatérale :	Dominant	Non dominant
- Complète	80	75
- Moyenne	30 à 70	25 à 65
- Légère	10 à 25	10 à 20

IV.2.1.8. Atteinte de la fonction du langage

Dysarthrie	
- Légère	5 à 15
- Importante	15 à 60
Atteinte complète de l'expression verbale	
Le blessé ne peut pas communiquer avec ses semblables ni en exprimant sa pensée ni en comprenant ce qui a été dit	100

IV.2.1.9. Nerfs crâniens

Séquelles résultant d'une atteinte du trijumeau	
*séquelles sensitives :	
• Anesthésie simple sans douleur	5 à 10
• Névralgie intense et persistante	10 à 60
*séquelles motrices :	
• Atteinte unilatérale	5
• Atteinte bilatérale	20 à 30
Séquelles résultant d'une atteinte du facial	
*troubles sensitifs :	
Les troubles sensitifs n'entraînent aucune incapacité fonctionnelle.	
*troubles moteurs :	
• Paralyse de type périphérique totale et définitive	20 à 30
• Paralyse de type périphérique partielle et définitive	10 à 30
• Paralyse bilatérale suivant l'intensité et l'état des réactions électriques	20 à 30
• Contracture post paralytique ou héli spasme facial, suivant déformation du visage	10 à 20
Séquelles résultant d'une atteinte du glossopharyngien	
• Paralyse unilatérale (fausse route)	10
• Paralyse bilatérale (exceptionnelle)	20
Séquelles résultant d'une atteinte du spinal	
L'atteinte d'un nerf spinal peut déterminer une atrophie du trapèze et sterno-cléido-mastoïdien (chute de l'épaule, faiblesse de la main unilatérale).	
Selon la gêne apportée dans l'activité du blessé et le côté atteint	15 à 30

Les atteintes des autres nerfs crâniens sont étudiées dans les chapitres traitant de la fonction à laquelle ils participent (**organes des sens en particulier**).

En cas d'atteinte simultanée de plusieurs nerfs crâniens, les taux seront évalués selon le degré des troubles fonctionnels globaux sans que la somme des taux puisse dépasser **100%**.

IV.2.1.10. Séquelles psychonévrotiques

- Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses. En règle générale les accidentés ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général des troubles de la conscience **30 à 100**
- Syndrome psychiatrique post-traumatique **20 à 100**
- Névrose post-traumatique **20 à 40**

IV.2.2. Séquelles provenant de l'atteinte diffuse des hémisphères ou du tronc cérébral

- Grande indifférence, passivité, absence de réactivité. Cette situation est secondaire à un coma prolongé avec réanimation respiratoire	100
- Le sujet a un aspect normal, mais il présente des troubles sévères de l'attention du jugement ; son activité est réduite	40 à 80
- Troubles amnésiques avec baisse considérable de l'affectivité, parfois une euphorie paradoxale ou au contraire un état de dépression est constaté	30 à 80

IV.2.3. Séquelles propres à l'atteinte médullaire

IV.2.3.1. Syndromes atrophiques

*Au membre supérieur

	Dominant	Non dominant
- Atteinte à prédominance proximale de la ceinture scapulaire et du bras, sans retentissement sur la fonction de la main	20 à 40	20 à 35
- Atteinte prédominante distale intéressant la fonction de la main ou de l'avant-bras	30 à 70	30 à 60
- Atteinte complète avec impotence totale d'un membre supérieur	90	80

*Au membre inférieur

- Atteinte à prédominance proximale de la ceinture pelvienne, sans retentissement sur la fonction du pied	40 à 60
- Atteinte prédominant aux muscles de la cuisse	20 à 40
- Atteinte à prédominance distale intéressant la fonction du pied et de la jambe	25 à 50
- Atteinte complète avec impotence absolue du membre inférieur	75

IV.2.3.2. troubles sphinctériens et génitaux

Rétention et incontinence d'urine (se reporter au système génito- urinaire).

Troubles de la défécation : si les troubles peuvent être corrigés par les thérapeutiques habituelles d'évacuation rectale, il n'y a pas lieu d'estimer d'incapacité partielle de travail.

- Rétention rebelle, entraînant des symptômes de coprostase	10
- Incontinence incomplète	10 à 25
- Incontinence complète	70
- Troubles génitaux, abolition des érections ou diminution considérable, ne permettant pas les rapports sexuels	10 à 20
- Syndrome de la queue de cheval plus ou moins accentué, selon les troubles sphinctériens et génitaux associés	30 à 50

IV.2.4. Séquelles provenant indifféremment d'atteinte cérébrale ou médullaire

IV.2.4.1. Troubles moteurs

Hémiplégie - Impotence complète, avec trouble sphinctériens, avec ou sans aphasia, etc. - Conservation d'une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d'une certaine autonomie : • Côté dominant • Côté non dominant.....			100	
			60 à 80	
			50 à 70	
Monoplégie *Atteinte isolée d'un membre inférieur : - marche possible, mais difficile en terrain accidenté, pour monter des marches, longs trajets pénibles			30	
- marche difficile, même en terrain plat			40	
*Atteinte isolée d'un membre supérieur :			Dominant	Non Dominant
- préhension possible, mais avec gêne de la dextérité digitale			10 à 25	8 à 20
- préhension possible, mais sans aucune dextérité digitale			25 à 50	20 à 45
- mouvements du membre supérieur				
très difficiles			50 à 75	45 à 65
Impossibles			85	75
Atteinte de plusieurs membres (diplégie, triplégie, tétraplégie). Les deux membres supérieurs ou les deux membres inférieurs, ou un membre et les deux membres inférieurs, etc. il y'a lieu d'estimer séparément chaque incapacité, et d'en faire la somme. S'il s'agit des deux membres exerçant la même fonction, il y'a lieu de majorer cette somme de 10% , en raison de la synergie. De toute façon, le taux global ne peut en aucun cas dépasser 100% .			100	

IV.2.4.2. Troubles sensitifs

Ils ne sont pratiquement jamais isolés, et accompagnent les séquelles motrices, qu'ils peuvent aggraver. L'anesthésie d'une main équivaut à une paralysie partielle. La perte de la sensibilité entraîne en effet la perte de la précision et le contrôle de la forme du geste. L'incapacité sera donc évaluée globalement.

En cas de troubles sensitifs isolés : on tiendra compte de leurs répercussions sur l'utilisation du membre considéré.

Douleurs de type spino-thalamique :

- Douleur à type de brûlure permanente unilatérale plus ou moins étendue, exagérée par le frottement et les émotions 20 à 60
- Douleur avec impotence totale d'un membre 80

IV.2.5. Séquelles portant sur le système nerveux périphérique

Les taux d'incapacité indiqués s'appliquent à des paralysies totales et complètes et définitives.

En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d'incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle.

On estime généralement **six degrés de force musculaire** :

- **0** : aucune contraction visible, mais n'entraînant aucun déplacement ;
- **1** : ébauche de contraction visible, mais n'entraînant aucun déplacement ;
- **2** : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
- **3** : mouvement actif possible contre la pesanteur ;
- **4** : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
- **5** : force normale.

Les atteintes correspondant au **degré 0, 1, 2 ou 3** entraîneront l'application du taux entier.

Pour le degré 4, le taux sera diminué de **25 à 50** de sa valeur.

IV.2.5.1. Membre supérieur

	Dominant	Non dominant
- Paralyse totale du membre supérieur [degré 0, 1, 2, et 3]	90	80
<u>Plexusbrachial :</u>		
- Paralyse radiculaire supérieure type Duchenne-ERB (deltoïde, sus-épineux, biceps, brachial antérieur, coraco-brachial, long supinateur et parfois sous-épineux, sous scapulaire court supinateur et hémi diaphragme) [degré 0, 1, 2, et 3].....	55	45
- Paralyse radiculaire inférieure, type Déjerine-Klumpke (fléchisseurs des doigts et muscles de la main) [degré 0, 1, 2 et 3].....	65	55
- Paralyse isolée du nerf sous scapulaire (grand dentelé), [degré 0, 1, 2 et 3]	10	5
- Paralyse du nerf circonflexe (deltoïde, petit, rond) [degré 0, 1, 2 et 3] ...	35	30
- Paralyse du nerf musculo-cutané (biceps, brachial antérieur). La flexion de l'avant-bras sur le bras reste possible par l'action du long supinateur [degré 0, 1, 2 et 3]	25	20
<u>Paralyse du nerf médian :</u>		
A-Au bras : (rond-pronateur, fléchisseur commun superficiel, grand et petit palmaires, chefs externes du fléchisseur commun profond, long fléchisseur du pouce, carré pronateur, court abducteur et opposant du pouce, 2 premiers lombricaux) [degré 0, 1, 2, 3]	55	45
B- Au poignet : n'atteint que les muscles de la main énumérés ci-dessus [degré 0, 1, 2, 3]	45	35
<u>Paralyse du nerf cubital :</u>		
A- Au bras : (cubital antérieur, chefs internes du fléchisseur commun profond, muscles hypothénariens et interosseux, deux lombricaux internes, adducteurs du pouce et chef interne de son court fléchisseur) [degré 0, 1, 2, 3]	45	35
B- Au poignet : (muscles de la main ci-dessus, griffe cubitale) [degré 0, 1, 2, et 3]	35	25
<u>Paralyse du nerf radial :</u>		
A-au-dessus du coude (triceps brachial, anconé, long supinateur, 1er 2ème radial, court supinateur, extenseur commun et extenseur propre du pouce, index, auriculaire, cubital postérieur) [degré 0, 1, 2 et 3]	55	45
B - au-dessous du coude , les mêmes muscles, sauf triceps et long supinateur [degré 0, 1, 2 et 3]	45	35

IV.2.5.2. Membre inférieur

- Paralysie totale d'un membre inférieur (degré 0, 1, 2 et 3), flasque	75
- Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auquel se joignent les muscles innervés par la sciatique poplitée externe et la sciatique poplitée interne). Voir aussi «membre inférieur», séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0, 1, 2, et 3).....	60
- Paralysie du nerf sciatique poplitée externe (jambier antérieur, extenseur propre du gros orteil, extenseur commun, long et court péronier latéraux, pédieux) [degré 0, 1, 2 et 3]....	30
- Paralysie du nerf sciatique poplitée interne (poplitée, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) [degré 0, 1, 2, et 3]	30
- Paralysie du nerf crural (quadriceps) [degré 0, 1, 2 et 3]	40
- Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) [degré 0, 1, 2 et 3]	15

IV.2.5.3. Névralgies sciatiques

Pour les névralgies sciatiques l'I.P.P. sera évaluée selon les perturbations fonctionnelles constatées (se rapporter au Rachis).

IV.2.6. Syndrome algodystrophique**IV.2.6.1. Algodystrophie du membre supérieur**

Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et l'atteinte articulaire :	
• Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence	10 à 20
• Forme sévère avec impotence et troubles trophiques sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance	30 à 50
• Forme avec troubles neurologiques (voir le point correspondant).	

IV.2.6.2. Algodystrophie du membre inférieur

Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche	10 à 30
• Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence	10 à 20
• Forme sévère avec impotence et troubles trophiques sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance	30 à 50

V. OTO- RHINO-LARYNGOLOGIE

V.1. Nez

V.1.1. Fractures

- Fractures des os propres du nez ou de la cloison avec gêne respiratoire sans sténose 4
- Troubles esthétiques par mutilation ou déformation nasale : Déformation de la pyramide nasale, Post-traumatique, selon gêne à la respiration, défiguration 5 à 30

V.1.2. Sténose nasale

Sténose unilatérale :	- Simple diminution du calibre de la narine ou de la fosse nasale	2
	- Formation de croûtes, rhino-pharyngite	4
	- Sténose totale avec retentissement tubo-tympanique ou sinusien, sans sinusite suppurée	6 à 10
Sténose bilatérale :	-Diminution de la perméabilité ne dépassant pas le tiers de la perméabilité physiologique	4
	- Diminution plus accentuée avec croûtes, rhinopharyngite, etc.	8
	- Sténose serrée avec respiration exclusivement buccale et troubles à distance	15 à 20
	- Troubles fonctionnels entraînant une perturbation bilatérale nasale..	4 à 6

V.1.3. Perforation de la cloison nasale

En général, elle n'entraîne pas d'incapacité. Cependant des phénomènes irritatifs peuvent se manifester autour de la perforation.

Accompagnée de phénomènes irritatifs 3

V.1.4. Rhinites crouteuses (après perte de substance endo-nasale étendue)

- Unilatérale 4
- Bilatérale 8

V.1.5. Troubles olfactifs

- Anosmie et troubles divers de l'olfaction 5 à 8
- Anosmie avec coefficient professionnel 10 à 20

V.2. Sinus

V.2.1. Sinusite maxillaire chronique

- Unilatérale 5 à 8
- Bilatérale 10 à 13
- Sinusite maxillaire suppurée 10

V.2.2. Sinusites fronto-ethmoïdales ou Sphénoïdales

- Sinusite Unilatérale 15 à 20
- Sinusite Bilatérale 25 à 30

V.2.3. Cranio-Hydrorrhée (voir « neurologie »)

- Cranio-hydrorrhée non compliquée 30
- Cranio-hydrorrhée compliquée de méningite à répétition 60

V.3. Pharynx

- Gêne à la déglutition par rétrécissement 5 à 35

V.4. Larynx**V.4.1. Troubles vocaux**

- Dysphonie seule 5 à 8
- Aphonie sans dyspnée 30

V.4.2. Troubles respiratoires

- Dyspnée d'effort 20 à 40
- Trachéotomie sans port d'une canule 50
- Trachéotomie avec port d'une canule 80 à 100

V.5. Oreilles**V.5.1. Mutilations et cicatrisations vicieuses de l'oreille externe**

- Perte du pavillon d'une oreille 2
- Perte du pavillon des deux oreilles 6
- Déformation cicatricielle du pavillon 2 à 10
- Sténose unilatérale 1 à 5
- Sténose bilatérale 1 à 10

La sténose du conduit auditif externe favorise la rétention dans le fond du conduit ou entraîne son obstruction fréquente :

- Otorrhée tubaire unilatérale 1 à 5
- Otorrhée tubaire bilatérale 1 à 8
- Otite suppurée chronique avec ostéite unilatérale 5 à 10
- Otite suppurée chronique avec ostéite bilatérale 5 à 15

V.5.2. Vertiges et troubles d'équilibre

- Vertiges sans signes labyrinthiques objectifs mais avec petite atteinte cochléaire à type de scotomes sur les aigües, attestant une légère commotion labyrinthique	5
- Vertiges s'accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tel nystagmus spontané ou de position, ou asymétrie dans les réponses. Nécessité de certaines restrictions dans l'activité professionnelle et dans la vie privée	10 à 15
- Vertiges vestibulaires au cours des épreuves avec inexcitabilité unilatérale	20
- Vertiges avec inexcitabilité bilatérale	25
La surdité sera calculée à part.	

V.5.3. Surdit 

L'I.P. P est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évalu e en tenant compte des donn ees acoum triques (**voix haute, voix chuchot e, montre, diapason**), des examens audiom triques et  ventuellement de l'audition apr s proth se.

Il faut  tre attentif   la fr quence de la simulation et l'exag ration des troubles de l'audition. Leur d pistage n'est pas toujours ais . On sera donc parfois amen    r p ter les  preuves dites de «**sinc rit **».

Surdit  unilat rale :

- Faible 0   3
- Moyenne 10   15
- Absolue 20

Surdit  bilat rale :

- Faible 5   20
- Moyenne 25   35
- Forte 40   50
- Absolue 60

OREILLE LA PLUS SOURDE

OREILLE NORMALE OU LA MOINS SOURDE	Voix haute									
	Distance de perception en mètres									
	5		4		2		1		0,25	
	contact		non perçue							
	Voix chuchotée									
	Distance de perception en mètres									
	0,80		0,5		0,25		0,10		contact	
	Non perçue									
			Perte auditive en décibels		0 à 25		25 à 35		35 à 45	
			45 à 55		55 à 65		65 à 80		80 à 90	
5	0,80	0 à 25	0	3	5	8	12	15	20	
4	0,50	25 à 35	3	8	12	15	20	25	30	
2	0,25	35 à 45	5	12	18	24	30	35	40	
0,25	Contact	45 à 55	8	15	24	35	40	45	50	
Contact	non perçue	55 à 65	12	20	30	40	50	60	60	
non perçue		65 à 80	15	25	35	45	60	70	70	
		80 à 90	20	30	40	50	60	70	70	

V.5.4. Acouphènes

Acouphènes (bourdonnement) gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l'acuité auditive **2 à 5**

V.5.5. Oreille moyenne

- Perforation du tympan, post-traumatique, sans suppuration	3 à 5
Otorrhée chronique :	
- Tubaire unilatérale	3 à 5
- Tubaire bilatérale	5 à 8
- Suppurée chronique unilatérale	5 à 10
- Suppurée chronique bilatérale	4 à 15
Ces taux s'ajoutent au taux résultant de la perte auditive éventuellement associée.	

V.5.6. Oreille Externe

*Sténose du conduit auditif externe favorisant la rétention dans le fond du conduit, ou entraînant son obstruction fréquente, sans surdité :	
- unilatérale	2 à 3
- Bilatérale	3 à 6
*Sténose très serrée entraînant une surdité : il y a lieu de calculer la perte auditive, compte tenu des possibilités d'audioprothèse	
*Déformation, cicatrice ou amputation du pavillon, suivant l'importance de la mutilation.....	1 à 10

VI. OPHTALMOLOGIE

VI.1. Altération de la fonction visuelle

VI.1.1. Cécité

- Cécité complète (avec attribution de la tierce personne) 100
- Quasi-cécité 100
- Quasi-cécité professionnelle non récupérable 100

VI.1.2. Scotome central bilatéral

Avec conservation des champs visuels périphériques selon la nature de l'activité 50 à 90

VI.1.3. Perte complète de la vision d'un œil (l'autre étant normal)

- Perte de la vision d'un œil, sans difformité apparente 30
- Ablation ou altération du globe avec possibilité de prothèse 33
- Sans prothèse possible 40

VI.1.4. Scotome central unilatéral

- Sans perte du champ visuel périphérique 15 à 18
- Avec perte du champ visuel périphérique 30

VI.1.5. Diminution de la vision des deux yeux

Le degré de vision sera apprécié en fonction de la correction optique (se reporter au tableau d'évaluation de l'incapacité visuelle).

VI.1.6. Vision périphérique du champ visuel

VI.1.6.1. Lacune unilatérale du champ visuel

- Déficit en îlot (localisation centrale ou, périphérique, temporale ou nasale, supérieure ou inférieure)	5 à 15
- Rétrécissement sensiblement concentrique du champ visuel (taux à ajouter à celui attribué éventuellement à la diminution de l'acuité visuelle)	
centrale à 30° :	
- un seul œil	3 à 5
- les deux yeux	5 à 20
Moins de 10° :	
- Un seul œil	10 à 15
- Les deux yeux	70 à 80

VI.1.6.2. Scotomes centraux

- un œil (suivant le degré de vision) 15 à 20
- les deux yeux (suivant le degré de vision) 50 à 90

VI.1.6.3. Hémianopsie

***hémianopsie** avec conservation de la vision centrale :

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - Homonyme droite ou gauche | 30 à 35 |
| - Hétéronyme binasale | 15 à 20 |
| - Hétéronyme bitemporale | 40 à 80 |
| - Horizontale supérieure | 10 à 15 |
| - Horizontale inférieure | 30 à 50 |

***les quadranopsies** peuvent être évaluées en assignant à chaque quadrant une valeur de :

	O.D		O.G	
	—		—	
Tempe droite	5	2	2	5
	15	8	8	15
		Nez		Tempe gauche

***scotomes paracentraux hémianopsiques** : quoique respectant la vision centrale qu'ils affleurent par leur limite, ils peuvent être très gênants lorsqu'ils ont la forme :

- | | |
|---|----------------|
| D'un scotome paracentral bitemporal | 10 à 15 |
| D'un scotome hémianopsique latéral droit qui entrave la lecture | 10 à 30 |

Hémianopsie avec perte de la vision centrale : uni ou bilatérale (ajouter à ces taux celui indiqué par le tableau d'évaluation de l'incapacité visuelle sans que le total ne puisse dépasser 100)

VI.1.7. Vision binoculaire

Le déséquilibre de la fonction qui permet aux deux yeux de fixer le même objet entraîne une diplopie persistante non améliorée par le traitement 5

VI.1.8. Troubles du sens chromatique et du sens lumineux

Ces troubles, dont l'origine traumatique isolée est très rare, sont des symptômes de lésion de l'appareil nerveux sensoriel ; il entre en ligne de compte dans l'appréciation de l'incapacité due à ces lésions.

VI.1.9. Cas particuliers**VI.1.9.1. Taies de cornée**

L'évaluation est faite d'après le tableau d'évaluation de l'acuité visuelle, mais elle sera minorée en fonction de la conservation du champ visuel périphérique.

VI.1.9.2. Taie centrale

La vision diminue lorsque la pupille se rétrécit : (**travail en pleine lumière, travail de près**).
En cas de photophobie entraînant l'éblouissement de l'autre œil, il sera ajouté un taux de **5%**.

Paralysie de l'accommodation et du sphincter irien

Ophtalmoplégie interne totale	
- unilatérale	10 à 15
- Bilatérale	15 à 20
Mydriase existant seule et déterminant des troubles fonctionnels :	
- Unilatérale	3 à 5
- Bilatérale	7 à 10

VI.1.10. Cataractes : traumatiques ou professionnelles

VI.1.10.1. Unilatérales

- **Non opérées ou inopérables** : le taux d'incapacité sera fixé après l'évaluation du degré de vision.
- **Opérées ou résorbées** : si la vision, après correction est égale ou inférieure à celle de l'œil non atteint de cataracte, ajouter (en raison de l'impossibilité de fusion des images et de la nécessité de porter un verre) **10%** sans que le taux médical puisse dépasser **20%**.

VI.1.10.2. Bilatérales

L'aphakie bilatérale comporte une incapacité de base de **20%**, à laquelle on ajoutera le taux d'incapacité correspondant à la diminution de la vision centrale, sans que le taux puisse dépasser **100%**.

VI.1.11. Cas divers

Les hypertopies oculaires, les luxations du cristallin, les hémorragies intraoculaires, les troubles du vitré, les altérations de la rétine, seront évaluées selon le degré de vision.

VI.2. Annexes de l'œil

VI.2.1. Orbites

- Nerfs moteurs : paralysie d'un ou plusieurs nerfs oculomoteurs (voir diplopie) En cas de paralysie consécutive à une affection du système nerveux central, se reporter à l'affection causale. - Nerfs sensitifs : névrites, névralgies très douloureuses, en particulier douleurs glaucomateuses, lésions du nerf trijumeau (symptômes neuro-paralytique, y compris les troubles de la sécrétion lacrymale, ou sa perte) à ajouter au taux correspondant aux troubles visuels..... - Altérations vasculaires : (anévrisme, etc.) ; indemniser les troubles fonctionnels (se reporter au tableau d'évaluation de l'incapacité visuelle).	10 à 20
--	----------------

VI.2.2. Paupières

- Déviation des bords palpébraux (entropion, trichiasis, ectropion, cicatrices vicieuses, symblépharon, ankyloblépharon), suivant étendue ; ajouter à la diminution de la vision et à la défiguration éventuelle	5 à 10
- Ptosis ou blépharospasme non volontaire : taux fondé sur le degré de vision et suivant que, en position primaire (regard horizontal de face, la pupille est plus ou moins découverte :	
- un œil	5 à 15
- les deux yeux	20 à 40
- Lagophtalmie cicatricielle ou paralytique ; ajouter aux troubles visuels 10% pour un œil.	
- Voies lacrymales : larmolement par lésion des voies lacrymales (atrésie, sténose)	5 à 10
- Fistules (résultant par exemple de dacryocystite ou de lésions osseuses) ; pour chaque œil	10 à 15

VI.2.3. Squelette orbitaire

- Déformation importante (plus éventuellement les séquelles ophtalmologiques) **5 à 15**

TABLEAU D'ÉVALUATION DE L'INCAPACITÉ EN RAPPORT AVEC UN TROUBLE DE LA VISION

La vision d'un œil est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité.

degré de vision	9/10	8/10	7/10	6/10	5/10	4/10	3/10	2/10	1/10	1/20 et moins de 1/20	enucléation
9/10	0	0	0	1	2	4	8	15	19	30	33
8/10	0	0	1	2	4	5	12	17	21	30	33
7/10	0	1	3	4	6	7	14	19	22	32	35
6/10	1	2	4	6	8	9	18	21	24	35	40
5/10	2	4	6	8	10	11	20	23	26	40	45
4/10	4	5	7	9	11	13	22	25	30	45	50
3/10	8	12	14	18	20	22	25	35	45	55	60
2/10	15	17	19	21	23	25	35	50	60	75	80
1/10	19	21	22	24	26	30	45	60	80	90	95
1/20 et – de 1/20	30	30	32	35	40	45	55	75	90	100	100
enucléation	33	33	35	40	45	50	60	80	90	100	100

Tous ces taux pourraient être diminués, en raison de la conservation du champ visuel périphérique, cette diminution ne pouvant dépasser **20%**.

VII. STOMATOLOGIE

VII.1. Face

En dehors de la fonction elle-même, le médecin expert pourra avoir à tenir compte des déformations entraînées par les cicatrices. Dans ce cas, il se reportera au point « **Téguments** ».

Le taux résultant des lésions sera estimé en fonction des pertes de dents (**évaluées à part**), de l'état de l'article dentaire et de la possibilité d'une prothèse susceptible de rétablir un coefficient de mastication suffisant.

Le coefficient de mastication se calcule en attribuant aux dents un coefficient particulier : **1 pour une incisive, 1 pour une canine, 1,25 pour une prémolaire, 1,5 pour une molaire**, et en faisant le total des dents existantes ayant une homologue sur la mâchoire opposée.

VII.2. Maxillaire (maxillaire supérieur)

Fractures	
- Vicieuse consolidée avec mauvais articulé dentaire, gêne notable de la mastication	10
- Avec engrenement très réduit ou inexistant entre les dents supérieures et inférieures	25
Pseudarthroses	
- Mobilité d'une partie importante du maxillaire supérieur avec mastication difficile, le déficit dentaire étant estimé en sus	30 à 40
- Mobilité d'un petit fragment du maxillaire supérieur (ablation en général)	10 à 30
Cal vicieux	
- Enfoncement et bascule postérieure (faux prognathisme). Troubles sérieux de l'articulé dentaire, pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de prothèse et défiguration	15 à 40
- Trouble léger de l'articulé dentaire par consolidation vicieuse d'une fracture du maxillaire supérieur	5 à 15
Enfoncement du malaire	
Apprécié en raison de la défiguration et des phénomènes nerveux	5 à 15
En cas de troubles oculaires, ceux-ci devront être évalués par un ophtalmologiste.	
Perte de substance	
- de la voûte palatine, respectant l'arcade dentaire et permettant une prothèse	5 à 10
- du voile du palais (non opéré), entraînant des troubles de la parole et de la déglutition ...	15 à 30
- partielle du maxillaire ne permettant pas une prothèse fonctionnellement satisfaisante sera évaluée par référence aux pertes de dents	5 à 20

VII.3. Mandibule (maxillaire inférieur)

Fractures consolidées avec articulé normale sans gêne fonctionnelle appréciable	0
Consolidation vicieuse	
- avec troubles de l'articulé dentaire, non compris une défiguration éventuelle permettant une prothèse	5 à 15
- avec troubles graves pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de prothèse	15 à 40
- avec engrenement très réduit ou inexistant	25 à 30
Perte de substance ou pseudarthrose	
- avec gêne de la mastication ou impossibilité de prothèse, selon son siège et son degré de mobilité	5 à 40
- avec perte de substance partielle de la mandibule, sans interruption de la continuité osseuse, et ne permettant pas une prothèse fonctionnellement satisfaisante	5 à 20
Les pertes partielles permettant une prothèse fonctionnellement satisfaisante seront évaluées par référence aux pertes de dents.	

VII.4. Articulation temporo-mandibulaire**VII.4.1. Constriction des mâchoires**

L'ouverture de la bouche est considérée comme gênante en dessous de **3 cm** entre les arcades. Pour apprécier le degré d'incapacité, on mesurera soigneusement la distance séparant les incisives, quelle que soit la cause de la constriction :

- Ecartement inférieur à 10 mm **20 à 50**
- Ecartement inférieur à 20 mm, mais supérieur à 10 mm **10 à 20**
- Ecartement supérieur à 20 mm **5 à 10**

VII.4.2. Luxation temporo-maxillaire

- Irréductible avec ouverture permanente de la bouche **10 à 50**
- Récidivante **5 à 10**
- Syndrome de Costen (craquements, douleurs controlatérales, difficulté d'ouverture, latéro-déviation possibles) **2 à 15**

VII.5. Langue

Amputations :	
- Amputation partielle entraînant une gêne à la mastication et à la déglutition	10 à 20
- Amputation étendue avec troubles plus accusés	20 à 75
- Amputation totale	80
Paralysie de la langue :	
- Incomplète	5 à 15
- Complète	50
Fistule salivaire à la peau	20

VII.6. Névralgies

Névralgies du sous-orbitaire, du mentonnier, etc. ; se reporter aux “**Nerfs crâniens**”.

VII.7. Dents

Perte de dents : les taux proposés ci-dessous sont ceux correspondant à la perte de dents.

- Perte d'une dent sans possibilité de prothèse, quelle qu'elle soit	1,50
- perte de toutes les dents, sans possibilité d'appareillage	48
En cas de possibilité d'appareillage, les taux seront diminués, compte tenu de la qualité du mode de restauration :	
• Prothèse fixe, réduction de 75%	
• Prothèse mobile, réduction de 50%	
- Perte de toutes les dents, correctement appareillées :	
Par une prothèse fixe	10,5
Par une prothèse mobile	21
Perte de substance osseuse accompagnant la perte d'une ou plusieurs dents : le taux retenu sera augmenté de 10 à 20% selon l'importance de la perte de substance.	
- Perte de vitalité d'une ou plusieurs dents : par dent	0,50

VII.8. Pharynx

Gêne de la déglutition par rétrécissement **5 à 35**

VII.9. Cicatrices du visage, des lèvres et de la muqueuse buccale

Se reportera au point « **Téguments** ».

VIII. APPAREIL DIGESTIF

VIII.1. Bouche et pharynx

Se reporter au point « STOMATOLOGIE » : sphère maxillo-faciale.

VIII.2. Œsophage

L'estimation de l'incapacité se fera d'après la dysphagie, les douleurs, les vomissements pouvant exister. Il importe également de prendre en considération le retentissement sur l'état psychique.

- Trouble léger avec dysphagie intermittente sans sténose avec dyskinésie 10
- Séquelles avec sténose organique partielle nécessitant des traitements prolongés 30 à 50
- Sténose totale s'opposant à l'alimentation orale 80

VIII.3. Estomac-duodénum

Ce seront souvent les séquelles de lésions traumatiques, elles sont souvent des séquelles chirurgicales, pour l'estimation, prendre en considération le volume de l'estomac et la perméabilité du duodénum :

- Troubles légers 10
- Troubles moyens 20 à 30
- Troubles graves 50 à 70

Ulcère aggravé par le traumatisme :

Si réaction douloureuse épigastrique, adhérence (etc...) le taux moyen 20

VIII.4. Intestin grêle (jéjunum, iléon)

Très souvent, il s'agit d'une atteinte directe, avec contusion ou rupture, désinsertion mésentérique ; cela peut être l'aggravation d'un état antérieur : angiopathie, angiomatose, maladie de Crohn, jéjuno-iléite, assez souvent, ce sont des séquelles post-opératoires.

- Troubles légers	10
- Troubles moyens avec nécessité d'une diététique particulière	20 à 30
- Troubles graves : trouble de l'absorption avec diarrhée, nécessite de bilan d'hépatologie, d'études des selles et du transit répétés	50 à 70
Fistule du grêle (duodénum, jéjunum, iléon) :	
- Assujettissement propre de la fistule	25
- Fistules étroites	20 à 30
- Fistules larges, bas situées	40 à 70
- Fistules larges, haut situées	70 à 90

VIII.5. Colon

Résultant d'une atteinte directe ou d'une aggravation d'un état antérieur (diverticulose, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique etc...).

Les séquelles sont caractérisées par des troubles de transit, du météorisme, et une alternance de constipation et de diarrhée, un écoulement (glaires), des éléments hémorragiques, des poussées douloureuses. Il existe un problème de diététique, un retentissement sur l'état général et sur la capacité de travail. Un bilan biologique et un transit sont indispensables.

- Troubles légers	10
- Troubles moyens	20 à 30
- Troubles graves	50 à 70
- Fistule stercorale intermittente	25
- Anus contre-nature	60
- En cas d'addition à d'autres troubles	10 à 30

VIII.6. Rectum et anus

Les lésions sont en général occasionnées par un emplacement ou un éclatement par air comprimé.

On tiendra compte de la rectite, de la colostomie éventuelle (voir plus haut), de la sténose rectale, de l'incontinence anale, y compris les séquelles de l'opération de Babcock, prolapsus, retentissement génital (surtout chez l'homme) :

- Troubles légers 10
- Troubles moyens 30 à 50
- Troubles graves..... 50 à 70

Fistules anales	- Fistule intra-sphinctérienne sous-cutanée	5
	- Fistule trans ou extra-sphinctérienne à trajet simple avec incident évolutif mineur et rare	10 à 15 20 à
	- Fistule complexe avec nombreux accidents évolutifs	30

VIII.7. Paroi abdominale

- Cicatrices vicieuses ou chéloïdes (imposant une protection au cours du travail) 5 à 10
- Rupture isolée du grand droit 10
- Hernie ou éventration sans cicatrice consécutive à des ruptures musculaires étendues 10 à 40

Pour les autres cicatrices de la paroi abdominale, se reporter au point « **Téguments** ».

VIII.8. Hernies

Il y'a lieu de s'assurer qu'il s'agit des hernies traumatiques avec des signes d'effraction tissulaires à savoir : douleurs reflexes, syncopes, nausées et ecchymoses.

Hernie inguinale opérée sans séquelle		0
Hernie inguinale opérée avec séquelle médiocre indemnisée comme cicatrice		
- Hernie peu volumineuse, non douloureuse, non scrotale, facilement réductible		5
- Hernie scrotale plus ou moins réductible		8
- Hernie volumineuse, douloureuse, difficilement réductible ou Irréductible		20
Hernie bilatérale, selon caractère, taux maximum		25
Eventration	- Petite	5
	- Moyenne	15
	- Grande	30 à 40

Hernies diaphragmatiques

L'estimation se fera d'après les troubles digestifs, respiratoires et généraux présentés par la victime :

- Troubles modérés 10 à 20
- Troubles importants 20 à 40

VIII.9. Fonction hépatobiliaire

Les traumatismes du foie ne lèsent pas habituellement les fonctions hépatiques.

Une éventuelle hépatite virale imputable au traitement nécessité par l'accident ne peut justifier l'attribution d'une I.P.P que dans la mesure où les examens biologiques objectivent des séquelles intéressant les fonctions hépatiques.

- Contusion du foie 10
- Fistule biliaire ou purulente traumatique ou postopératoire 20 à 60

VIII.10. Fonction pancréatique exocrine

(Pour la fonction pancréatique endocrine, voir « Glandes endocrines »).

Des lésions pancréatiques peuvent être provoquées par des traumatismes abdominaux, contusion, hématome, déchirure, rupture, d'où peuvent résulter des troubles digestifs et des fistules. Il est d'autre part admis qu'une pancréatite aiguë puisse apparaître dans les heures ou les jours suivants le choc initial.

A distance, la formation d'un pseudo-kyste ou la constitution d'une pancréatite chronique peut être rattaché à un traumatisme antérieur.

Pour la réparation, on tiendra compte des répercussions, de l'atteinte pancréatique sur l'état général, des problèmes nutritionnels qu'elle pose, des douleurs qui en résultent et des séquelles chirurgicales éventuelles (fistule pancréatique, suppuration chronique, etc.).

La coexistence de troubles de la régulation glycémique entraîne par ailleurs une diminution de la capacité de la victime et doit être évaluée à part, les deux taux s'additionnant.

VIII.11. Rate

Splénectomie

- Bonne cicatrisation pas de modification de la formule sanguine 10
- Cicatrice plus ou moins insuffisante, éventration, modification plus ou moins importante de la formule sanguine 40

IX. APPAREIL RESPIRATOIRE

IX.1. Paroi thoracique

- Fracture de côtes, selon l'intensité de la douleur 2 à 5
- Fracture de côtes à type de volet thoracique avec déformation 5 à 10
- Fracture du sternum :
 - Avec gêne et douleur à l'effort 2 à 5
 - Avec enfoncement et douleur à l'effort 5 à 15

IX.2. Atteinte de la fonction respiratoire

Insuffisance respiratoire légère	Dyspnée d'effort, anomalies radiologiques, à l'exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) déficit léger (capacité vitale entre 60 et 70% de la valeur théorique), indice de Tiffeneau entre 60 et 70%	10 à 30
Insuffisance respiratoire moyenne	Dyspnée disproportionnée à l'effort, anomalies radiologiques (principalement diminution notable de la cinématique thoraco-diaphragmatique). A l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit notable (capacité vitale en dessous de 60% de la valeur théorique, indice de Tiffeneau en-dessous de 60%)	30 à 50
Insuffisance respiratoire importante	Dyspnée marquée au repos, cyanose plus ou moins prononcée, tachycardie, toux productive, diminution importante du jeu thoraco-diaphragmatique, augmentation de l'aire cardiaque avec débord des cavités droites, à l'électrocardiogramme cœur pulmonaire chronique, altération plus au moins importante de l'état général, à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit important	50 à 100

IX.3. Cas particuliers

- Tuberculose pulmonaire stabilisée, lorsqu'elle a été imputée à un traumatisme ou reconnue aggravée par celui-ci. Le taux d'I.P.P. devra être fixé en fonction des séquelles définitives, voir « Atteinte de la fonction respiratoire ».	
- Pneumothorax par rupture de bulles, l'estimation des séquelles tiendra compte de l'importance de l'insuffisance respiratoire (on recourra avec prudence aux épreuves fonctionnelles respiratoires en cas de pneumothorax récidivant).	
- Fistule d'un pyothorax selon la taille de la cavité pleurale résiduelle et l'importance de la suppuration	10 à 20
- Rétrécissement de la trachée	10 à 20
A ces taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour les troubles de la fonction respiratoire des lésions pleuro-pulmonaires associées.	
- Trachéotomie :	
. sans port de canule	50
. avec port de canule	80 à 100

X. APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE

X.1. Cœur

X.1.1. Insuffisance cardiaque

Légère	Troubles aux efforts prolongés. Nécessité d'une thérapeutique et d'une surveillance discontinues. Pas de symptômes de décompensation, peu de retentissement sur la vie professionnelle	10 à 30
Moyenne	Absence de symptômes au repos. Troubles survenant à l'effort et aggravés par lui. Petits signes d'insuffisance cardiaque cédant bien au traitement, nécessité d'une surveillance suivie. Modification de l'image radiologique. Quelques perturbations dans la vie professionnelle	30 à 60
Grave	Symptomatologie susceptible de se manifester au repos. Accidents d'asystolie. Nécessité d'un traitement et d'un régime suivis. Chute de la pression artérielle. Silhouette cardiaque élargie. Image pleuro-pulmonaire de "poumon cardiaque". Vie professionnelle très perturbée ou impossible	60 à 100

X.1.2. Péricarde

Suites de péricardite ou de blessure du péricarde (à évaluer selon l'atteinte de la fonction cardiaque).

X.1.3. Myocarde

Au cas où l'imputabilité a été retenue : 1- séquelle d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G. des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques	20 à 30
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré. 2- troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur	10 à 20

X.1.4. Endocarde

Les séquelles de lésions valvulaires d'origine traumatique ou post-traumatique (notamment infectieuses), justiciables ou non d'un traitement chirurgical, seront à évaluer selon les troubles fonctionnels et le degré d'insuffisance cardiaque.

X.2. Atteintes vasculaires

X.2.1. Aorte

- Anévrisme aortique (si l'imputabilité a été admise) 80 à 100

- Anévrisme aortique opéré bien contrôlé 30 à 40

- Anévrisme aortique opéré, mal contrôlé ;

Les séquelles seront appréciées selon l'importance des troubles, en tenant compte des séquelles pariétales.

X.2.2. Autres artères

A- Anévrisme des artères périphériques succédant à des traumatismes ouverts ou fermés. L'évaluation de l'incapacité se fera d'après les troubles constatés (voir "Oblitération artérielle"). B- Anévrisme artério-veineux, selon le siège, l'importance des vaisseaux concernés, et les manifestations périphériques	10 à 20
En cas de retentissement cardiaque, à ce taux sera ajouté le taux correspondant au degré d'insuffisance cardiaque. C- Oblitération artérielle (si l'imputabilité est admise), y compris celle résultant d'une ligature secondaire à une blessure. Le taux d'incapacité sera estimé selon les signes cliniques, oscillométriques et angiographiques. L'oblitération artérielle se traduit par des signes fonctionnels à l'effort ou au repos (douleurs, crampes), des troubles trophiques et même des ulcérations. On distinguera aussi bien aux membres inférieurs qu'aux membres supérieurs : - une forme légère 20 à 30 - une forme moyenne 30 à 50 - une forme grave 50 à 70	

X.2.3. Veines et lymphatiques

Les varices par elles-mêmes ne donnent pas lieu à une évaluation d'invalidité.

Troubles phlébitiques et troubles trophiques veineux et lymphatiques : troubles des tissus cutanés et sous-induration cellulitiques, lymphœdème, éléphantiasis, ulcère variqueux persistant, etc... : • forme légère 5 à 10 • forme moyenne 10 à 20 • forme grave 20 à 30	
---	--

X.3. Hypertension artérielle

Il faudra éliminer au préalable toute hypertension artérielle antérieure à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

L'indemnisation portera sur l'état hypertensif et ses retentissements viscéraux :

- élévation de la tension artérielle **10 à 20**
- retentissements viscéraux (en fonction de l'organe atteint).

XI. APPAREIL URINAIRE

XI.1. Rein

XI.1.1. Néphrectomie

- Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative 15 à 20
- Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative,
mais avec une grande éventration lombaire 30 à 40

XI.1.2. Hématurie

- Hématurie isolée ou protéinurie isolée 5 à 10

XI.1.3. Insuffisance rénale

- Insuffisance rénale légère : clairance supérieure aux trois quarts de la normale ; vie professionnelle normale	10 à 20
- Insuffisance rénale moyenne : clairance entre un quart et trois quarts ; peu de retentissement sur la vie professionnelle	20 à 40
- Insuffisance rénale importante : clairance normale, anémie, goutte éventuelle, modification humorale, nécessité en particulier de mesures diététiques ou autres plus ou moins astreignantes, retentissement professionnel ne permettent pas un travail régulier ou à temps complet	40 à 60
- Insuffisance rénale avancée nécessitant un traitement de suppléance (hémodialyse), l'appréciation tiendra compte de l'anémie, des autres manifestations et des difficultés éventuelles d'application de la méthode et des incidences sur l'activité professionnelle	50 à 100

XI.1.4. Transplantation rénale

- Séquelles de transplantation rénale, selon les conséquences du traitement immunodépresseur, et de la valeur
fonctionnelle du rein greffé 30 à 100

XI.1.5. Traumatisme rénal

- Séquelles anatomiques de traumatisme rénal 15 à 30

XI.1.6. Hypertension secondaire à une lésion rénale traumatique

(Voir Appareil cardio-vasculaire).

XI.2. Bassinet-uretère

XI.2.1. Hydronéphrose

- hydronéphrose bien tolérée 10 à 20
- hydronéphrose compliquée (crises douloureuses, infections) 20 à 40

En cas de bilatéralité, ces taux ne s'additionnent pas et l'expert appréciera en fonction, et en particulier, l'insuffisance rénale.

XI.2.2. Lithiase

On ajoutera éventuellement le taux de l'insuffisance rénale ou de l'infection urinaire associée.

XI.2.3. Séquelles de lésions urétérales

- Séquelle de rupture d'uretère bien tolérée 10 à 20
- Mal tolérée ou avec fistule ou péri néphrite 40 à 50
- Urétérostomie cutanée, permanente ou chirurgicale :
 - Unilatérale 60
 - Bilatérale ou sur rein unique 80

XI.3. Vessie et urètre

XI.3.1. Tumeur

- Tumeur vésicale selon le type histologique, l'étendue des lésions et les thérapeutiques nécessitées 30 à 80
- Tumeur vésicale maligne avec infiltration de la muqueuse 100

XI.3.2. Infection

- Infection chronique ou à répétition du bas appareil 10 à 30

XI.3.3. Rétention

Rétention d'urine chronique :

- Sondage pluri-hebdomadaire ou sonde à demeure 50
- Cystostomie 60

XI.3.4. Fistule

- incontinence permanente des urines, nécessitant le port d'un appareil collecteur 60

(Sera ajouté, éventuellement, le taux estimé pour d'autres manifestations en cas de blessures médullaires, et, éventuellement, les taux correspondant à un retentissement rénal).

XI.3.5. Pollakiurie

- pollakiurie simple, avec réduction de la capacité vésicale objectivée par des examens complémentaires 10 à 25

XI.3.6. Entérocystoplastie

- Entérocystoplastie d'agrandissement (y compris les complications infectieuses) 30 à 50
- Entérocystoplastie (type Bricker) 60

XI.3.7. Dysurie

- Dysurie : débit mictionnel supérieur à 10 ml / second 10

XI.3.8. Rétrécissement

- Rétrécissement, sans retentissement sur le bas ou le haut appareil, sans infection, ne nécessitant que quelques dilatations annuelles 20
- Rétrécissement avec retentissement sur le bas ou le haut appareil 30 à 50

Ce taux est éventuellement majoré en raison des complications éventuelles : insuffisance rénale, lithiase, abcès du périnée, fistules, impuissance, etc ...

- séquelles de rétrécissement urétral ayant nécessité une chirurgie réparatrice 15 à 30

XI.4. Eventration

- Eventration hypogastrique après intervention sur le système urinaire :
 - Petite 5
 - Moyenne 15
 - Grande 30 à 40

XII. APPAREIL GENITAL

XII.1. Appareil génital masculin

- Perte de la verge, compte tenu du méat périnéal et des troubles psychiques en résultant...	50 à 60
- Perte d'un testicule (atrophie, destruction ou orchidectomie).....	10 à 20
- Castration bilatérale, selon les résultats du traitement substitutifs ou du traitement hormonal	30 à 50
- Emasculation totale (perte des testicules et du pénis)	60 à 80

XII.2. Appareil génital féminin

- Prolapsus utérin (dans les cas exceptionnels où l'origine traumatique sera reconnue)	
• cas légers	2 à 10
• cas graves (avec incontinence d'urine à l'effort)	30
Cicatrices vulvaires ou vaginales gênantes (taux pouvant être majoré en cas de retentissement fonctionnel important)	5 à 10
- Perte anatomique ou fonctionnelle des deux ovaires chez une femme en période d'activité génitale	30 à 50
- Hystérectomie	30 à 50

- Amputation d'un sein 5 à 20

- Amputation des seins 6 à 30

XIII. GLANDES ENDOCRINES

Les glandes endocrines se trouvent assez rarement lésées lors des traumatismes, du fait de leur situation anatomique protégée. En outre, une faible partie du parenchyme endocrinien suffit à maintenir la fonction hormonale, ce qui, en particulier dans le cas d'organes pairs, pour éviter les perturbations importantes des métabolismes.

XIII.1. Séquelles hypophysaires

- Diabète insipide post-traumatique 10 à 30
- Syndrome d'hypopituitarisme antérieur (selon le degré de déficit et le résultat du traitement 60 à 70

XIII.2. Séquelles surrénaliennes

- Maladie d'Addison post-traumatique, selon le résultat du traitement 40 à 70

XIII.3. Séquelles thyroïdiennes

- Maladie de Basedow, selon l'intensité de symptômes 5 à 40

A ce taux, s'ajoutera éventuellement un taux pour complications cardiaques (**voir appareil cardio-vasculaire**), sans que la somme des deux puisse dépasser **100 %**.

XIII.4. Séquelles parathyroïdiennes

- **Hyperparathyroïdie légère**, crises tétaniques et spasmes viscéraux rares. Peu de modifications des épreuves biologiques. Retentissement léger dans la vie professionnelle 10 à 30
- **Hypoparathyroïdie compliquée**, aux taux précédents, il convient d'ajouter les taux résultant de l'atteinte fonctionnelle des organes concernés.

XIII.5. Séquelles du pancréas endocrine

- Diabète sucré équilibré par un régime et la prise d'hypoglycémifiants oraux 5 à 10
- Diabète sucré nécessitant un régime strict et l'emploi de l'insuline 30 à 40
- Diabète sucré avec incidents d'acidose ou de coma. Régime strict, amaigrissement, difficulté d'un régime équilibré par l'insuline 40 à 70

Lors des révisions, les complications (artérite, rétinite, atteinte rénale, etc.), seront évaluées selon le déficit fonctionnel de l'organe atteint (**voir "Appareil cardio-vasculaire, "Séquelles ophtalmologiques, appareil urinaire etc.)** et s'ajouteront aux taux ci-dessus, le taux global ne pouvant excéder **100%**.

XIV. TEGUMENTS

XIV.1. Cicatrices

XIV.1.1. Cicatrices du cuir chevelu, perte des cheveux

- Scalp total ou brûlures étendues du cuir chevelu, avec phénomène douloureux 30
- Scalp ou brûlure partielle du cuir chevelu, selon l'étendue des cicatrices douloureuses (**névrome**) ou de l'alopecie post-traumatique 5 à 20

XIV.1.2. Cicatrices disgracieuses du visage gênant la mimique

Selon déformation, étendues, gêne aux mouvements du visage, selon le siège des déformations, notamment de l'atteinte des orifices naturels 5 à 30

XIV.1.3. Cicatrices des mains

Disgracieuses, chéloïdiennes du dos de la main, indépendamment des raideurs ou rétractions :

- Une main 5
- Les deux mains 10

XIV.1.4. Cicatrices vicieuses et chéloïdes

- Imposant une protection au cours du travail, suivant le siège et l'extension 5 à 10
- De la plante du pied, gênant la marche 10 à 20
- De la plante du pied, très importante et rendant impossible le port de chaussures 20 à 25

XIV.1.5. Cicatrices de la paroi abdominale

Cicatrices ou éviscérations :

- Cicatrices sans éviscération très larges adhérentes, limitant les mouvements du tronc 10 à 30
- Cicatrices avec éviscération postopératoire après cure radicale 5 à 30
- Cicatrice avec éviscération après laparotomie (appareillage ou non) 15 à 50
- Rupture isolée du grand droit de l'abdomen 8 à 20
- Hernie ou éviscération sans cicatrices consécutives à des ruptures musculaires étendues 10 à 40
- Eventration hypogastrique 10 à 20

XIV.2. Tétanos

Quand il guérit, le tétanos laisse rarement des séquelles, mais il faut prendre en charge les séquelles définitives laissées parfois par la thérapeutique (**voir chapitres correspondants du barème**).

Séquelle d'une atteinte de tétanos :

- mauvais état général, déficience organique post-infectieux, reliquats articulaires, sériques, asthénie 10
- troubles neurologiques consécutifs au tétanos :
 - Accidents parétiques ou paralytiques, gêne respiratoire par parésie diaphragmatique, troubles cardiaques etc..... 30
 - Accidents dus à l'emploi du sérum antitétanique 20 à 100

XIV.3. Cancer se développant sur une cicatrice :

Si l'état peut être considéré comme fixé, l'on estimera le taux d'incapacité selon le déficit fonctionnel subsistant (aspect, amputations, limitations, etc.)

XIV.4. Dermo-épidermite

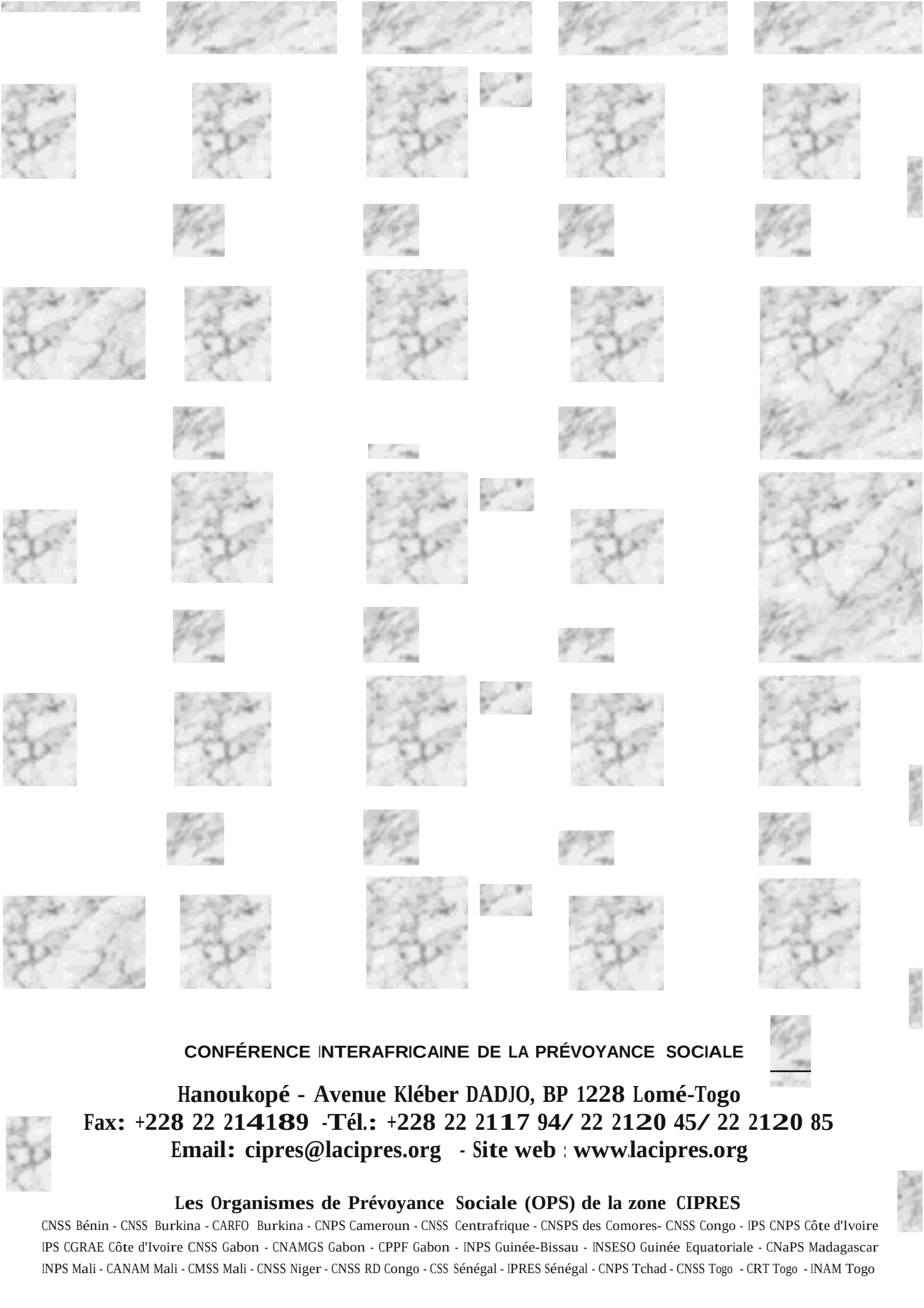
Consécutive à une atteinte accidentelle des téguments, non compris les éléments qui peuvent être retenus pour l'évaluation de l'incapacité (étendue de la lésion, fréquence des poussées, prurit, nécessité d'un traitement, répercussions professionnelles) **5 à 10**

XIV.5. Fistules à la peau

Consécutive à une mauvaise résorption de fils de suture ou à toute autre cause avec écoulement, et suivant le nombre **1 à 8**

XV. BIBLIOGRAPHIE

- 1- Paul Mathieu, Paul Padovani. *Guide barème des accidents du travail et des maladies professionnelles*. Edition Poinat, Paris, 1960.
- 2- Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS) de France.
Barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles.
Paris : UCANSS (éditeur), 1998, 446 p., tabl., ann., ISSN 1281-0827, FRA
- 3- Lucien Mayet, Etienne Rey. *Barème des accidents du travail et des maladies professionnelles*.
Volume 347, édition Poinat, Paris, 1956.



CONFÉRENCE INTERAFRICAINNE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

Hanoukopé - Avenue Kléber DADJO, BP 1228 Lomé-Togo

Fax: +228 22 214189 -Tél.: +228 22 2117 94/ 22 2120 45/ 22 2120 85

Email: cipres@lacipres.org - Site web : www.lacipres.org

Les Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) de la zone CIPRES

CNSS Bénin - CNSS Burkina - CARFO Burkina - CNPS Cameroun - CNSS Centrafrique - CNSPS des Comores- CNSS Congo - IPS CNPS Côte d'Ivoire
IPS CGRAE Côte d'Ivoire CNSS Gabon - CNAMGS Gabon - CPPF Gabon - INPS Guinée-Bissau - INSESO Guinée Equatoriale - CNaPS Madagascar
INPS Mali - CANAM Mali - CMSS Mali - CNSS Niger - CNSS RD Congo - CSS Sénégal - IPRES Sénégal - CNPS Tchad - CNSS Togo - CRT Togo - INAM Togo